ГОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия

Минздравсоцразвития России

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ

В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Киров
2011

УДК 616.3-07(075.8)
ББК 54.13я73
С30

Печатается по решению центрального методического совета Кировской государственной медицинской академии, протокол №

Семиотика и синдромология в гастроэнтерологии: учебное пособие для студентов медицинских вузов / сост. А. Я. Чепурных, Е. В. Пояркова, Н. В. Коновалова, Р. А. Шамсутдинова. - Киров: Кировская государственная медицинская академия, 2011. -143 с

Учебное пособие посвящено самостоятельной подготовке к практическим занятиям по разделу гастроэнтерология, содержит перечень контрольных вопросов, набор ситуационных задач, тестовых заданий к каждому занятию в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов по специальности «Лечебное дело» и « Педиатрия».

Рецензент: заведующий кафедрой госпитальной терапии КГМА доктор медицинских наук профессор Б.Ф. Немцов.

© Чепурных А.Я, Пояркова Е.В., Коновалова Н.В., Шамсутдинова Р.А. – Киров, 2011
© ГОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие…….5

Методические указания……7

Глава 1 Семиотика и синдромология заболеваний пищевода……..8

1.1 Расспрос больного при заболеваниях пищевода……8

1.2 Данные объективных методов исследования……10

1.3 Данные дополнительных методов исследования…….....11

1.4 Синдромы при заболеваниях пищевода……..11

1.5 Частная патология ……12

Глава 2 Семиотика и синдромология заболеваний желудка…..……...14

2.1 Расспрос больного при заболеваниях желудка……..……..14

2.2 Данные объективных методов исследования……..……..…19

2.3 Данные дополнительных методов исследования…… …21

2.4 Синдромы при заболеваниях желудка……....26

2.5 Частная патология ……....32

Глава 3 Семиотика и синдромология заболеваний кишечника……..34

3.1 Расспрос больного при заболеваниях кишечника……34

3.2 Данные объективных методов исследования……...39

3.3 Данные дополнительных методов исследования……41

3.4 Синдромы при заболеваниях кишечника……...44

2.5 Частная патология …….....55

Глава 4 Семиотика и синдромология заболеваний поджелудочной. железы……58

4.1 Расспрос больного при заболеваниях поджелудочной железы…..58

4.2 Данные объективных методов исследования……...61

4.3 Данные дополнительных методов исследования……64

4.4 Синдромы при заболеваниях поджелудочной железы……..66

4.5 Частная патология ……...70

Глава 5 Семиотика и синдромология заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей…… 71
5.1 Расспрос больного при заболеваниях желчного пузыря……..…..71
5.2 Данные объективных методов исследования……...74
5.3 Данные дополнительных методов исследования…….78
5.4 Синдромы при заболеваниях желчного пузыря ……..……..82
5.5 Частная патология ……...86
Глава 6 Семиотика и синдромология заболеваний печени……89
6.1 Расспрос больного при заболеваниях печени…….……..… ..89
6.2 Данные объективных методов исследования……...93
6.3 Данные дополнительных методов исследования…….100
6.4 Синдромы при заболеваниях печени…….. ……..……..102
6.5 Частная патология ……...118
Контрольно-обучающий блок……120
Список рекомендуемой литературы……. 141
Заключение……..142

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной целью курса пропедевтики внутренних болезней в соответствии с государственной программой обучения в медицинском вузе является освоение студентами основ клинического обследования больных, семиотики и синдромологии внутренних болезней, а также овладение основами клинического мышления.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в гастроэнтерологии. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного – сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. Подобной подход полностью соответствует современным представлениям о высокой информативности результатов клинических исследований в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Правильно проведенное клиническое обследование позволяет определить причину развития диспептического синдрома более, чем у 90% больных гастроэнтерологического профиля. Анализ его особенностей при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря способствует развитию клинического мышления у студента третьего курса медицинского вуза.

Достаточно полно представленные дополнительные методы обследования больных, в том числе и специальные, применяемые в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Показания к включению этих методов в план обследования больного в зависимости от особенностей клинической картины

заболевания логически обоснованы и направлены на формирование навыков диагностики на уровне отдельного синдрома.

Подобное изложение материала оказывает существенную помощь при самоподготовке к практическим занятиям, и, не дублируя материал, излагаемый в учебнике по пропедевтике внутренних болезней и на лекциях, повышает качество обучения и способствует наиболее эффективному освоению учебного материала.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я

Учебное пособие “Семиотика и синдромология в гастроэнтерологии” предназначено студентам 3 курса лечебного и педиатрического факультетов медицинских вузов для изучения симптомов и основных синдромов в гастроэнтерологии. Цель учебного пособия: способствовать формированию основных профессиональных навыков обследования больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, развитию основ клинического мышления, рационального использования лабораторных и инструментальных методов обследования. Учебное пособие включает задачи: освоение методики и получение практических навыков обследования больных, выявление ведущих клинических синдромов, составление плана обследования и лечения.

Согласно учебной программе длительность изучения тем по семиотике и синдромологии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта составляет: 12 часов лекционных, 28 часов практических занятий и 21 час самостоятельной работы для студентов лечебного факультета и 6 часов лекционных, 14 часов практических и 10,5 часов самостоятельной работы для студентов педиатрического факультета.

Учебное пособие состоит из 6 глав. В первой главе рассматриваются симптомы и синдромы при заболеваниях пищевода; во второй – при заболеваниях желудка, в–третьей при заболеваниях кишечника и в четверной при заболеваниях поджелудочной железы и в пятой – при заболеваниях желчного пузыря, в шестой при заболеваниях печени. В каждой главе излагаются жалобы, особенности анамнеза, данные объективных и инструментальных методов исследования, патогенетически обосновываются основные синдромы при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В конце учебного пособия предлагаются контрольные вопросы, тестовые задания и пример решения ситуационных задач.

ГЛАВА 1
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА

1.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА

1.1.1 ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

- Дисфагия
- Одинофагия
- Эзафагодиния
- Регургитация (пищеводная рвота)

Дисфагия – расстройство акта глотания, возникает в течение нескольких секунд после начала глотания. Выделяют две группы причин пищеводной дисфагии:

а) механического характера вследствие обструкции просвета пищевода (стриктура, опухоль), либо сдавления извне (рак легкого, увеличение лимфатических узлов средостения, аневризма аорты, выраженный зоб);

б) функционального характера вследствие нарушения моторики – диффузный эзофагоспазм, ахалазия кардии, системная склеродермия.

Больные с механической обструкцией пищевода испытывают дисфагию при проглатывании главным образом твердой пищи. Дисфагия носит постоянный характер и нарастает по мере прогрессирования сужения просвета пищевода.

У больных с нарушениями моторной функции пищевода дисфагия одинаково выражена при приеме как твердой, так и жидкой пищи. Дисфагия наблюдается эпизодически, не прогрессирует, либо прогрессирует очень медленно. Обычно периоды нормального глотания чередуются с периодами дисфагии, которая, как правило, умеренно выражена. Дисфагия может

провоцироваться проглатыванием большого пищевого комка, приемом холодной или горячей пищи, стрессами.

Одинофагия - боли различной интенсивности, возникающие при прохождении пищи по пищеводу. Имеют чаще всего загрудинную локализацию, связаны с приемом пищи и сочетаются с дисфагией. Проходят самостоятельно либо после приема антацидов или глотка воды.

Эзафагодиния - боли за мечевидным отростком, не связанные с приемом пищи. По характеру - тупые, ноющие, в виде изжоги или чувства распирания, постоянные или приступообразные, с иррадиацией в нижнюю челюсть, шею, плечи, межлопаточную область в зоне V-VII грудных позвонков и по межреберьям. Купируются приемом спазмолитиков, аналгетиков, жидкостей, применением грелки на область грудины.

Регургитация (пищеводная рвота) **-** представляет собой ретроградное поступление эзофагеального содержимого в полость рта без предшествующей тошноты и без участия мышц передней брюшной стенки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Изжога - ощущение жжения или жара у мечевидного отростка грудины, связано с раздражением дистального отдела пищевода кислым желудочным содержимым или щелочным секретом двенадцатиперсной кишки, имеющем в своем составе желчные кислоты и панкреатические ферменты. Изжога обычно возникает после еды, особенно после приема жирной и острой пищи, томатов, шоколада, алкоголя, а также после курения. Она может усиливаться в горизонтальном положении больного, при наклоне вперед, при метеоризме, подъеме тяжестей, ношении тугого пояса

Отрыжка - обусловлена сокращением мускулатуры желудка на фоне расслабления нижнего пищеводного сфинктера. Может быть горьким, кислым содержимым, а также съеденной пищей. Обычно отрыжка наблюдается при наличии гастроэзофагеального рефлюкса.

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА у больных с заболеваниями пищевода: слабость, недомогание, потливость, повышение температуры.

1.1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Начало заболевания постепенное при хроническом эзофагите, раке пищевода. Дисфагия постепенно нарастает при приеме преимущественно твердой пищи. Внезапное начало наблюдается при ахалазии кардии. Дисфагия возникает непостоянно (при волнениях, быстрой еде, недостаточном пережевывании пищи), провоцируется какими-либо определенными продуктами, может носить парадоксальный характер (плотная пища проходит по пищеводу лучше чем жидкая, а большие количества пищи лучше, чем маленькие)

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

При сборе анамнеза жизни у больных с заболеваниями пищевода необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Ранее перенесенные заболевания: склеродермия, анемия.
2. Травмы.
3. Курение.
4. Злоупотребление алкоголем, шоколадом, кофе, цитрусовыми.
5. Лекарственные воздействия.

1.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

При общем осмотре следует обратить внимание на:

- Снижение массы тела и общее истощение пациента, которое может быть связано с нарушением попадания пищи в желудок при раке и ахалазии пищевода.

- Возможно выявление признаков системного заболевания, например, системной склеродермии (характерная амимия лица, уплотнения кожи и пр.).

  При пальпации можно выявить увеличенные лимфоузлы в над/подключичной и подмышечной областях при раке пищевода.

1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения двигательной функции пищевода применяются инструментальные методы:

1. Манометрия
2. Рентгенография
3. Эзофагоскопия

Манометрия – метод, позволяющий получить информацию о состоянии эзофагеальной мускулатуры. Применяется для диагностики заболеваний пищевода: идиопатической дискинезии, ахалазии кардии, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагитов.

Рентгенография – метод, позволяющий наблюдать за движением контрастного вещества по пищеводу, т.е. за выполнением пищеводом его основной пропульсивной функции, так при длительно сужении пищевода происходит значительное расширение участка, расположенного выше места сужения.

Эзафагоскопия – метод, позволяющий провести осмотр слизистой оболочки с помощью оптического прибора эзофагоскопа. Применяется как с диагностической, так и с лечебной целью. Позволяет сделать биопсию – иссечение кусочков ткани для последующего гистологического исследования.

1.4 СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА

1. ПИЩЕВОДНАЯ ДИСПЕПСИЯ (дисфагия, регургитация)
2. БОЛЕВОЙ

- Одинофагия
- Эзафагодиния

3. КЛИНИКО – АНЕМНЕСТИЧЕСКИЙ

1.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭЗОФАГИТ - воспаление слизистой оболочки пищевода продолжительностью более 6 месяцев.

Причины: грибы рода Candida, herpes simples, цитомегаловирус; прием лекарственных препаратов: доксициклин, калия хлорид, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды; профессиональные факторы: пары концентрированных кислот, щелочей, солей тяжелых металлов; травматизация слизистой оболочки горячей, острой, слишком холодной, грубой пищей; полигиповитаминоз, недостаточность железа в организме.

Основные синдромы:

1. Синдром пищеводной диспепсии:
   - Дисфагия
   - Регургитация
2. Болевой синдром:
   - Одинофагия
   - Эзафагодиния
3. Клинико-анамнестический

АХАЛАЗИЯ КАРДИИ (КАРДИОСПАЗМ) – отсутствие рефлекторного раскрытия кардии при глотании и сопровождающиеся нарушением перистальтики и снижении тонуса грудного отдела пищевода.

Причины: нарушение центральной нервной регуляции пищевода после стрессовых ситуаций и употребление очень холодной пищи.

Основные синдромы:

1. Пищеводная диспепсия

- Дисфагия (затруднение происхождения и твердой, и жидкой пищи)
- Регургитация

2. Болевой синдром
    - Одинофагия
    - Эзафагодиния
3. Клинико-анамнестический

РАК ПИЩЕВОДА

Основные синдромы:

1. Синдром пищеводной диспепсии
    - Дисфагия
2. Болевой синдром
    - Одинофагия
    - Эзафагодиния
3. Клинико-анамнестический

ГЛАВА 2
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА

2.1 РАССПРОС БОЛЬНЫХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

2.1.1 ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

- Боли
- Диспепсические жалобы (отрыжка, изжога, рвота, нарушение аппетита, неприятный вкус в полости рта

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

Локализация. При хроническом гастрите (ХГ), язвенной болезни с локализацией язвенного дефекта в препилорической и пилорической области, а также в луковице 12 перстной кишки (ДПК) боли локализуются в эпигастральной области. При локализации язвы в постбульбарном отделе ДПК боль ощущается в спине или правой подложечной области. При язвах и раке кардиального отдела желудка часто наблюдается атипичная локализация боли за грудиной или слева от нее. В этом случае следует проводить дифференциальную диагностику со стенокардией. Если боль, типичная для ХГ и язвенной болезни меняет свою локализацию и начинает отдавать (иррадиировать) в спину, межлопаточную область, в нижнегрудной отдел позвоночника, то следует думать об осложнение язвенной болезни - пенетрации, как правило в поджелудочную железу.

Время появление боли. При язвенной болезни имеет значение не столько качество пищи, сколько факт приема пищи. В связи с этим срок возникновения болей относительно момента приема пищи приобретает особое значение. По отношению ко времени приема пищи различают боли ранние, поздние, ночные и голодные.

Ранними называются боли, возникающие через 15-60 минут после еды, интенсивность их постепенно нарастает, боли беспокоят в течение 1.5-2 ч и затем по мере эвакуации желудочного содержимого постепенно исчезают. Ранние боли характерны для хронического гастрита, для язв и опухолевых процессов, локализованных в верхних отделах желудка.

Поздние боли появляются через 1.5-2 ч после еды и характерны, для язв с локализацией в нижней трети тела желудка.

Голодные (тощаковые) через 6-7 ч после еды, эти боли характерны для язв пилорического отдела и дуоденитов. Вариантом этих болей могут быть ночные, успокаивающиеся после приема пищи, молока. Таким образом, суточный ритм болей в зависимости от расположение патологического очага, может быт разный:

- при желудочных язвах “пища-боль-облегчение-пища-боль…”,
- при дуоденальных язвах “голод-боль-пища-облегчение-голод-боль…”.

Характер боли. У половины больных боли небольшой интенсивности тупые, ноющие, ощущения жжения указывают на раздражение слизистой оболочки желудка или 12-перстной кишки; спастические, сжимающие - коликообразные боли наблюдаются при гипертонусе (спазме) гладкой мускулатуры - кардиоспазме, спазме привратника; пронизывающие (кинжальные) боли наблюдаются при вовлечении в процесс серозных оболочек - прободной и пенетрирующей язвах, раке с инфильтрирующим ростом.

Периодичность боли. Для язвенной болезни характерна периодичность появления боли Обострение язвенной болезни продолжается от нескольких дней до 6-8 недель, затем наступает фаза ремиссии.

Сезонность болей. Обострение язвенной болезни чаще наблюдается весной и осенью. Эта “сезонность” боли особенно характерна для язвы 12-перстной кишки.

ДИСПЕПСИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ

Отрыжка - внезапное, непроизвольное выхождение через рот газов из желудка или пищевода. Отрыжка воздухом, пищей наблюдается при хроническом гастрите. Отрыжка, сопровождающаяся запахом тухлых яиц (сероводород) наблюдается, при хроническом атрофическом гастрите. Кислая отрыжка, сочетающаяся с гиперсекрецией желудочного сока возникает во время приступа болей при язвенной болезни. Горькая отрыжка появляется при забрасывании желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Отрыжка с гнилостным запахом характерна для больших расширений желудка, гипохлоргидрии или ахилии с застоем содержимого при рубцовоязвенном стенозе привратника, при раке желудка.

Изжога - ощущение жжения в эпигастральной области и за грудиной. Изжога возникает при желудочно-пищеводном рефлюксе. В ее возникновении играют роль повышенная чувствительность слизистой оболочки пищевода, дисфункция кардиального отдела желудка, спастическое состояне привратника, нарушение моторной функции нижнего отдела пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рвота - частичное или полное извержение желудочного содержимого через рот, а иногда и носовые ходы наружу. Возникает в результате нарушения эвакуаторной функции желудка, или при раздражении рецепторов слизистой оболочки желудка воспалительным процессом. При возникновении рвоты у больного необходимо уточнить:

- связь с болью или другими симптомами,
- связь с качественным составом и временем приема пищи,
- частота и кратность рвоты,
- характер рвотных масс.

При остром гастрите рвота повторно возникает вскоре после еды и приносит временное облегчение. Для хронического гастрита типична рвота натощак; рвотные массы содержат много слизи с незначительной примесью

плотных частиц, имеют кисловатый запах. При язвенной болезни рвота, как правило, возникает на фоне довольно сильных болей в животе и облегчает их; ей предшествует выраженная тошнота. Стеноз выходного отдела желудка сопровождается обильной рвотой с гнилостным запахом и примесью остатков пищи, съеденной накануне или несколько дней назад. При раке желудка рвотные массы из-за присутствия небольшого количества измененной крови становится коричневыми.

Нарушение аппетита (анорексия) - отмечается при хроническом гастрите с пониженной секреторной функцией, при расширении желудка, вызванном стенозом привратника, а также при раке желудка.

Неприятный вкус в полости рта - ощущение горечи, металлического или кислого привкуса имеют место при гастритах с секреторной недостаточностью.

Особенности диспептических жалоб при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью

- плохой аппетит, иногда тошнота,
- ощущение металлического привкуса во рту,
- отрыжка воздухом, пищей, иногда тухлым,
- чувство тяжести и перенаполнения в эпигастральной области после еды,
- тупые неинтенсивные боли в эпигастральной области, возникающие вскоре после еды,
- урчание и вздутие живота,
- наклонность к учащенному и жидкому стулу.

Особенности диспептических жалоб при язвенной болезни

- боли в эпигастрии различные, в зависимости от локализации язвенного дефекта: ранние при кардиальных язвах; поздние при язвах нижней трети желудка; голодные при препилорических и пилорических язвах,
- боли имеют четкую ритмичность (в зависимости от локализации язвенного процесса) и сезонность,

- изжога - характерный признак: иногда может быть единственным субъективным проявлением язвенной болезни,
- рвота возникает на высоте болей и приносит облегчение больному.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Дополнительные жалобы позволяют уточнить особенности функционального состояния слизистой оболочки желудка и возникают вследствие нарушения функции кишечника: метеоризм, нарушение стула в виде поносов или запоров.

- *Метеоризм* возникает при гастритах с пониженной кислотностью
- *Нарушение стула* проявляется в виде запоров или поносов

Поносы свидетельствуют в пользу гипохлоргидрии или ахлоргидрии, при гастритах с секреторной недостаточностью. Запоры, напротив, возникают при гиперацидизме, характерном для язвенной болезни 12-перстной кишки.

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА у больных с язвенной болезнью желудка и 12 п.к.: появление слабости, снижении трудоспособности, быстрой утомляемости, раздражительности. У больных раком желудка появляется стойкое снижение аппетита, иногда полная потеря его вплоть до отвращения к пище, иногда только к мясной.

2.1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Начало болезни. Хронический гастрит часто протекает как первично хроническое заболевание, т.е. не имеет эпизода острого начала, поэтому больные не могут определить дату начала заболевания.

При язвенной болезни больные как правило могут четко датировать время начала заболевания.

Характер течения болезни. Волнообразное рецидивирующее течение с четко выраженной сезонностью обострений характерно для язвенной болезни 12-перстной кишки. Постоянное течение характерно для хронического гастрита.

Причины обострений. При хроническом гастрите обострение связано с погрешностью в диете. При язвенной болезни обострения сезонны, часто связаны с психоэмоциональным перенапряжением.

Изменение характера болей и течения заболевания свидетельствует о присоединении осложнений.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Характер питания. Число приемов пищи и ее количество на один прием, регулярность в приеме пищи, степень пережевывания и темп еды имеет значение для возникновения хронического гастрита.

Вредные привычки. Употребление алкоголя, табакокурение способствуют развитию хронического гастрита и, в какой-то степени, язвенной болезни.

Наследственность. Имеет значение в возникновении язвенной болезни 12-перстной кишки.

Условия трудовой деятельности. Частые психоэмоциональные и физические нагрузки способствуют развитию язвенной болезни. Работа с ненормированным днем, невозможностью обеспечить рациональное питание в течение рабочего дня, способствует развитию хронического гастрита.

2.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.2.1 ОБЩИЙ ОСМОТР

При неосложненном течении заболевания данные общего осмотра мало информативны, т.е. существенных изменений может не наблюдаться. При язвенной болезни вследствие преобладания тонуса блуждающего нерва выявляются вегетативные кожные реакции: холодные, влажные ладони, мраморность кожи дистальных отделов конечностей, легкий тремор, яркий дермографизм. При длительной ахлоргидрии развивается нарушение ионизации и всасывания железа, и как следствие этого - бледность кожных покровов, сухость кожи, заеды в углах рта, ломкость ногтей, выпадение волос. Эти симптомы характерны для хронического атрофического гастрита. Землистая

бледность, значительное похудание, доходящее до кахексии, характерно для рака желудка. Бледность кожных покровов можно наблюдать после желудочных кровотечений.

2.2.2 ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА

Язык при ряде заболеваний имеет свои особенности: чистый и влажный - при язвенной болезни без сопутствующей патологии; обложенный серо-белым налетом, плохо пахнущий - при остром гастрите; обложенный беловатым налетом при хроническом гастрите и язвенной болезни с выраженными запорами; атрофия сосочков языка наблюдается при раке желудка, атрофическом гастрите с выраженным снижением секреторной функции желудка и недостаточности витаминов группы В. Наличие у больного сухого языка, шершавого, обложенного грязно-коричневым налетом указывает на развитие острой хирургической патологии брюшной полости.

2.2.3 ОСМОТР ЖИВОТА

При осмотре живота обращают внимание на форму и вид передней брюшной стенки. Втянутый живот ладьевидной формы характерен для перфорации полого органа. Резкое вздутие верхней половины живота - для острого расширения желудка. Если передняя брюшная стенка тонкая и дряблая, можно увидеть крупные опухоли, а также - перестальтические волны желудка при стенозе привратника различного происхождения.

2.2.4 ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА

При хроническом гастрите определяется разлитая болезненность в эпигастральной области. При язвенной болезни 12-перстной кишки - умеренная, а в период обострения выраженная болезненность в эпигастрии, как правило, локализованная на ограниченном участке. При язве желудка болезненность локализована преимущественно в центре эпигастрия или слева от срединной линии, при язве 12-персной кишки - справа от срединной линии. Локальное защитное напряжение передней брюшной стенки более характерно

для язвы 12-перстной кишки при обострении заболевания (вследствие развития перивисцерита).

2.2.5 ПЕРКУССИЯ ЖИВОТА

При легкой перкуссии живота иногда более четко выявляются участки болезненности, чем при пальпации. Локальная перкуторная болезненность в гастродуоденальной зоне называется симптомом Менделя. Симптом Менделя обычно указывает на то, что язвенный дефект не ограничен слизистой оболочкой, а распространяется во всех слоях стенки желудка или 12-персной кишки и сопровождается развитием перивисцерита.

Шум плеска определяется у здоровых людей после еды. Если шум плеска определяется через 7-8 часов и более после приема пищи, это указывает либо на значительную гиперсекрецию желудка, либо на снижение его эвакуаторной функции (чаще при стенозе привратника). Исчезновение перкуторной тупости над областью печени наблюдается при наличии воздуха в брюшной полости при перфорации язвы желудка.

2.2.6 АУСКУЛЬТАЦИЯ ЖИВОТА

Аускультация желудка практического значения не имеет.

2.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.3.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ

В клинической практике при исследовании кислотной продукции желудка используются два основных метода: **аспирационно-титрационный и внутрижелудочная pH-метрия.**

В основе аспирационно-титрационного метода лежит аспирация содержимого желудка с помощью тонкого зонда с последующим титрованием полученного содержимого. При этом определяется объем секреции натощак и после стимуляции гистамином (при субмаксимальной - гистамин вводят в дозе 0,008мг/кг, при максимальной - 0,025мг/кг), титрационная кислотность, дебит кислоты и пепсина и другие параметры с целью изучения

функционального состояния и потенциальных возможностей секреторного аппарата желудка.

Примечание: к парентеральным стимуляторам желудочной секреции относятся гистамин, гисталог, пентагастрин, инсулин и др. В настоящее время для стимуляции желудочной секреции широкое применение находит синтетический аналог естественного гастрина — пентагастрин. Он применяется в дозе 6 мкг/кг внутримышечно или подкожно, а в дозе 1,2 мкг/кг в течение часа — внутривенно.

В оценке кислотопродуцирующей функции желудка ориентируются на следующие показатели (табл 1).

Таблица 1

Нормальные показатели секреции желудка

Основные показатели секреции желудка	Секреция желудка			
	Натощак	Базальная	Субмаксимальная	Максимальная
Объем сока (мл/ч)	30-50	50-100	100-140	180-220
Обшая кислотность (тр.ед)	до 40	40-60	80-100	100-120
Свободная соляная кислота (титр.ед)	до 20	1,5-5,5	65-85	90 -110
Кислотная продукция-дебит час HCL (ммоль/л)	до 2	1,5-5,5	8-14	18-26

Для здоровых лиц отношение БКП : СМКП = 1 : 3; БКП : МКП = 1 : 6

При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью в базальном секрете отсутствует свободная соляная кислота, а максимальная секреция не превышает 5 ммоль /л.

При умеренном атрофическом гастрите максимальная секреция может колебаться в пределах нормы.

При атрофическом гастрите - как правило происходит сближение величины ВКП и МКП; БКП : МКП = 1 : 1,5 или 1 : 2

Желудочная секреция при язвенной болезни различается в зависимости от локализации язв. При язвах желудка с локализацией в теле и кардиальном отделе кислотообразующая функция может быть разной, но, как правило, она тем ниже, чем ближе к кардиальному отделу расположена язва. Соотношение БКП : МКП может быть 1: 3; 1: 4

При бульбарных и пилорических язвах кислотная продукция чаще всего значительно увеличивается как в базальную, так и в стимулированную фазу секреции. Базальное кислотовыделение, контролируемое преимущественно блуждающим нервом, превышает в 2 - 3 раза, а в ночное время в 3 - 4 раза. Здесь имеет значение как гиперваготония и гипергастринемия, так и структурные изменения слизистой оболочки, связанные с гиперплазией желудочных желез. Объем желудочного сока натощак при этом может доходить до 200 мл.

При раке желудка характер желудочной секреции зависит от степени распространенности и локализации опухоли, так при локализации в пилорическом отделе на ранних стадиях заболевания (при малом размере опухоли) кислотообразование может сохраниться или даже усилиться. При раке желудка, локализованном в теле, опухоль, как правило, сопровождается хроническим атрофическим гастритом, При этом обнаруживается стойкая гистаминорефрактерная ахлоргидрия. В поздних стадиях рака желудка развивается ахлоргидрия независимо от локализации опухоли. При этом в желудочном содержимом обнаруживается молочная кислота.

В настоящее время оценка секреторной функции желудка с использованием **pH-метрии** является наиболее информативной и совершенной.

В современной медицине pH-метрия применяется для проведения:

- топографической внутрижелудочной pH-метрии
- кратковременного (до 3 часов) исследования базальной и стимулированной секреции желудка

- длительного (до 24 часов и более) мониторинга гастроэзофагеальных рефлюксов
- исследования быстропротекающих кислотных процессов, типа дуоденогастральных рефлюксов
- пристеночной интраэндоскопическая pH-метрии
- подбора препаратов и их дозировок, оценки эффективности воздействия препаратов
- исследований, связанных с получением разрешений на применение тех или иных фармакологических препаратов в лечебной практике

Таблица 2

Оценка кислотопродуцирующей функции желудка по уровню pH

Состояние кислотообразования в теле желудка	Уровень pH	
	базальный	стимулированный
Гиперацидность, непрерывное кислотообразование	1,5 и ниже	1,2 и ниже
Нормацидность, непрерывное кислотообразование	1,6-2,0	1,2-2,0
Гипоацидность	2,1-6,0	2,1-3,0
Субанацидность		3,1-5,0
Анацидность	более 6,0	более 5,0

Кратковременная внутрижелудочная pH-метрия

Кратковременная внутрижелудочная pH-метрия используется для исследования кислотообразующей и кислотонейтрализующей функций желудка в базальных условиях и после стимуляции (гистамином или пентагастрином). При стандартной схеме проведения кратковременной pH-

метрии после введения зонда в желудок в течение 45 мин регистрируют базальный уровень pH, затем проводят *стимуляцию* желудочной секреции и опять записывают pH в течение 45 мин.

2.3.3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В настоящее время в связи с развитием фиброгастродуоденоскопии при хроническом гастрите и язвенной болезни желудка и 12 п.к. рентгенологическое исследование желудка утратило свое значение. Однако этот метод играет важную роль в диагностике опухолей желудочно-кишечного тракта, а также в выявлении их осложнений (стеноза желудка). Основным рентгенологическим симптомом язвенной болезни является симптом ниши; при стенозе выходного отдела желудка снижается тонус и наблюдается умеренное расширение желудка; при хроническом гастрите уменьшается выраженность складок слизистой оболочки желудка, и истонченность их, бледность, часто избыточное количество слизи, привратник зияет, перистальтика вялая.

2.3.4. ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ

Этот метод исследования позволяет выявить состояние слизистой:цвет, мельчайшие изменения поверхности - разрастания, эрозии, язвы. Дает представление и о состоянии сосудов, кровоизлияниях, отделении слизи. Путем ФГДС можно выявить нераспознанные при рентгенологическом исследовании опухоли, язвы, кровоточащие полипы желудка, дивертикулы и др.

2.3.5 ДИАГНОСТИКА ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ (HP) ИНФЕКЦИИ

Для диагностики **х**еликобактерной инфекции применяются следующие методы.

Цитологический позволяет определить наличие хеликобактерии в мазках отпечатках биоптотов слизистой оболочки желудка, полученных при ФГДС. Метод позволяет дать и дающий количественную характеристику обсемененности Нр.

- слабая (+) - до 20 микробных тел в поле зрения
- средняя (++) - до 50 микробных тел в поле зрения
- высокая (+++) - до 50 микробных тел в поле зрения

Уреазный тест позволяет определить присутствие Нр в биоптате после помещения его в индикаторную жидкость. При контаминации Нр материала индикаторная жидкость меняет цвет.

Иммунохимический метод с моноклональными антителами позволяет обнаружить антитела к Нр в биосредах (слизистая оболочка желудка, слюна кровь).

Бактериологический метод наиболее точный, основанный на выделении культуры Нр и дальнейшем изучении свойств этого микроорганизма.

Неинвазивные тесты Серологические методики: обнаружение АТ к *H. pylori* в сыворотке крови. Метод наиболее информативен при проведении эпидемиологических исследований. Клиническое применение теста ограничено тем, что он не позволяет дифференцировать факт инфицирования *H. pylori* в анамнезе от наличия в настоящий момент.

2.4 СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

1. СИНДРОМ ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

вследствие нарушения секреции пепсина и соляной кислоты:

- ацидизм
- гипоацидизм

вследствие нарушения эвакуации из желудка:

- демпинг синдром
- пилоростеноз

2. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
3. СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

- мальабсорбция (сидеропения, гиповитаминоз)
- ускоренная эвакуация (поносы)

- мальдигестия
- замедленная эвакуация (запоры)

4. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ
5. АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНЫЙ СИНДРОМ.
6. СИНДРОМ "МАЛЫХ" ПРИЗНАКОВ (ОПУХОЛЕВОГО РОСТА).

Примечание Термин "диспепсия" означает "Расстройство пищеварения". В зависимости от локализации поражения, следствием которого является диспепсия, различают несколько её видов: **пищеводная, желудочная, кишечная, панкреатическая, билиарная.**

СИНДРОМ ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

Желудочная диспепсия является ведущей при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки и тесно связана как с секреторными, так и с моторными нарушениями желудка.

В зависимости от механизма возникновения синдром желудочной диспепсии бывает различным: при усилении секреции пепсина и соляной кислоты возникает *ацидизм,* при снижении секреции пепсина и соляной кислоты - *гипоацидизм,* при ускорении эвакуации из желудка - *демпинг синдром,* при замедлении эвакуации - *синдром пилоростеноза*.

АЦИДИЗМ

Основные клинические признаки: Отрыжка кислым и изжога, связаны с регургитацией желудочного содержимого в пищевод и возникают при недостаточности кардии и повышении внутрижелудочного давления. Изжога в ряде случаев становится эквивалентом болей. Тошнота, отрыжка тухлым и рвота встречаются реже и возникают вследствие длительного спазма и/или выраженного воспалительного отека привратника или луковицы 12 п.к. Сохранение их в фазе ремиссии заболевания свидетельствует о рубцовом стенозе привратника. Рвота чаще появляется без предшествующей тошноты на высоте боли и приносит облегчение.

Данные осмотра: признаки вегетативной дисфункции вследствие преобладания тонуса блуждающего нерва: холодные, влажные ладони, мраморность кожи дистальных отделов конечностей, легкий тремор, яркий дермографизм.

Локальные данные: при обострении - умеренная локальная болезненность в эпигастрии или справа от срединной линии. Положительный симптом Менделя при наличии перевисцерита.

Лабораторно: количество желудочного сока натощак более 50 мл - увеличение кислотной продукции как в базальную, так и стимулированную фазу секреции. БПК превышает норму в 2-3 раза, а в ночное время в 3,5-4 раза. Уровень pH базальной секреции более 6, стимулированной - более 5.

Заболевания, сопровождающиеся синдромом ацидизма: хронический антральный гастрит, хронический дуоденит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

ГИПОАЦИДИЗМ

Основные клинические признаки: отрыжка воздухом, а при выраженной секреторной недостаточности - тухлым, съеденной пищей, горьким, тошнота, неприятный привкус во рту особенно по утрам, жжение в эпигатральной области, анорексия.

Данные осмотра: похудание, признаки полигиповитаминоза (при нарушении всасывания витаминов и железа в кишечнике)и сидеропении: бледность кожных покровов, сухость кожи, ухудшение зрения, заеды в углах рта, ломкость ногтей, выпадение волос.

Локальные данные: умеренная разлитая болезненность в зпигастральной области.

Лабораторно: снижение СМКП, величина сближается с БКП (в норме соотношение БКП : СМКП=1 : 3); дебит HCl не свыше 2 - 6 ммоль/л. Уровень pH базальной секреции 2,1- 6, стимулированной - 2,1-3

Заболевания, сопровождающиеся синдромом гипоацидизма: хронический атрофический гастрит, рак желудка.

ДЕМПИНГ-СИНДРОМ

Возникает вследствие ускоренной эвакуации из желудка при оперированном желудке. В ряде случаев сходная клиническая симптоматика развивается на фоне усиления моторной активности желудка зиянии привратника при ахлоргидрии.

Клинические признаки: после приема пищи, богатой углеводами, появляется резкая общая слабости, тошнота, потливость, головокружение, сердцебиение; бледность или покраснения кожи; тахикардия (реже-брадикардия); снижение артериального давления. При тяжелом течение появляются рвота, режущая боль в животе, урчание, ускоренная перистальтика, частый жидкий стул. Больной старается принять горизонтальное положение. В крови снижается уровень глюкозы (развивается гипогликемия).

ПИЛОРОСТЕНОЗ

Возникает при раке пилорического отдела, рубцово- язвенной деформации или полипе выходного отдела желудка.

Основные клинические признаки: выраженное чувство давления и полноты, особенно после приема пищи, время от времени спазмы в эпигастральной области (стенотическая перистальтика), тошнота, обильная рвота фонтаном с выделением большого количества разлагающегося на протяжении нескольких дней содержимого. Рвота приносит облегчение. Беспокоит отрыжка тухлым, сильная жажда. При длительно существующем стенозе возникает обезвоживание организма, скудный стул, истощение.

Локальные данные: при истощенной брюшной стенке можно видеть контуры расширенной границы желудка, спастические сокращения. При толчкообразной пальпации в области желудка - шум плеска натощак.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта не имеет чувствительной иннервации, поэтому патологические процессы (воспаление, язва, эрозии и др.) без секреторно-моторных расстройств органа болевого синдрома не вызывают. Более глубокие слои стенки желудка и 12 п.к. снабжены чувствительными окончаниями волокон симпатического нервного сплетения и реагируют на повышение внутриорганного давления или на растяжение серозной оболочки. Так, при распространении патологического процесса на мышечную и серозную оболочку органов, а также при функциональных расстройствах, приводящих к повышению внутриорганного давления, у больных возникает висцеральная боль. Если в патологический процесс вовлекается париетальный листок брюшины - возникает соматическая боль. Вот почему хронический поверхностный гастрит и язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки без нарушения секреторно-моторной функции могут не сопровождаться развитием болевого синдрома. В зависимости о локализации язвенного дефекта характер болевых ощущений может меняться (см табл 3).

Таблица 3

Особенности болей в зависимости от локализации язвенного дефекта при язвенной болезни

Локализация язвы	Происхождение боли	Характер боли	Локализация и иррадиация	Сопутствующие симптомы
Язва в пределах слизистой оболочки	Висцеральная боль	Жжение, тупая, ноющая	Без четкой локализации и иррадиации	Sp Менделя (-)
Язва в пределах стенки органа	Висцеральная с иррадиацией	Интенсивная без четкой локализации	Иррадиирует в позвоночник, левое и правое подреберье	Sp Менделя (+)
Пенетрирующая язва	Висцерально-соматическая	Интенсивная, постоянная,	Иррадиирует в спину или	Sp Менделя (+)

		ограниченная	в виде полупояса слева	
Воспаление париентальной брюшины	Соматическая	Внезапная, резко интенсивная	Распространенность по всему животу	Доскообразный живот, Sp Щеткина-Блюмберга (+)

СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

Синдром кишечной диспепсии при заболеваниях желудка и ДПК развивается в связи с нарушением функционального состояния желудка. Так, при снижении секреторной функции желудка (гипоацидизме) нарушается кишечное переваривание (мальдигестия), как правило осложненная кишечной гнилостной диспепсией (см. синдромы при заболеваниях кишечника). При длительно существующей мальдигестии, у больного может развиться нарушение всасывания (мальабсорбция), которая проявляется гипополивитаминозом и сидеропенией, то есть нарушением всасывания железа вследствие недостаточности его ионизации на фоне гипоацидного (анацидного) гастрита.

Нарушение двигательной функции кишечника также зависит от активности кислотно-пептического фактора. Так, гипоацидизм сопровождается ускоренной эвакуации химуса из кишечника, а ацидизм - замедленной эвакуацией.

АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНЫЙ СИНДРОМ

Обусловлен дисфункцией вегетативной нервной системы и преобладанием парасимпатического ее отдела.

Клинические признаки:

- холодные, влажные ладони, мраморность кожи дистальных отделов конечностей,
- легкий тремор, яркий дермографизм,

- лабильность пульса со склонностью к брадикардии,
- наклонность к артериальной гипотензии.

СИНДРОМ МАЛЫХ ПРИЗНАКОВ (ОПУХОЛЕГО РОСТА)

Этот симптомокомплекс характерен для ранних признаков рака желудка и обусловлен не грубыми анатомическими изменениями пораженного органа, а нарушениями обменного порядка. Встречается у 80% больных раком желудка. Клинические признаки:

- нарушение общего самочувствия, которое выражается в появлении беспричинной слабости, снижении трудоспособности, быстрой утомляемости,
- психическая депрессия - потеря интереса к окружающему, к труду, потеря радости жизни, апатия, отчужденность,
- стойкое снижение аппетита, иногда полная потеря его вплоть до отвращения к пище, иногда только к мясной,
- беспричинное прогрессирующее похудание,
- явления “желудочного дискомфорта” - потеря физиологического чувства удовлетворения от принятой пищи, ощущение переполнения и тяжести в эпигастральной области, иногда тошнота и рвота.

2.4 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ **-** хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, характеризующееся ее клеточной инфильтрацией, нарушением физиологической регенерации и вследствие этого атрофией слизистой эпителия, расстройством секреторной, моторной и инкреторной функций желудка.

Основные синдромы:

1. Синдром желудочной диспепсии.
   - гипоацидизм
   - демпинг синдром

2. Болевой синдром

3. Синдром кишечной диспепсии:

- мальдигестия, (гнилостная диспепсия)
- мальабсорбция (сидеропиния, поливитаминоз)
- ускоренная эвакуация (поносы)

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 12 ПЕРСТНОЙ КИШКИ – самостоятельное (первичное) хроническое рецидивирующее заболевание гастродуоденальной области с образованием язв.

Основные синдромы:

1. Синдром желудочной диспепсии.
   - ацидизма
   - пилоростеноза
2. Болевой синдром.
3. Синдром кишечной диспепсии.
   - замедленной эвакуации из кишечника (запоры)
4. Синдром астено-вегетативный

РАК ЖЕЛУДКА

Основные синдромы:

1. Синдром желудочной диспепсии.
   - гипоацидизм
2. Болевой синдром.
3. Синдром кишечной диспепсии.
   - мальдигестия, (гнилостная диспепсия)
   - мальабсорбция (сидеропиния, поливитаминоз)
   - ускоренная эвакуация (поносы)
4. Синдром малых признаков

ГЛАВА 3
СЕМИОТИКА И СИДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

3.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА

3.1.1 ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

- Расстройства стула (поносы, запоры, тенезмы)
- Метеоризм
- Боли в животе
- Кишечные кровотечения

Расстройства стула.

При заболеваниях кишечника расстройства стула могут проявляться в виде изменения частоты акта дефекации и/или нарушения физико-химических свойств каловых масс. Учащение акта дефекации или однократное опорожнение кишечника с выделением обильных жидких каловых масс называется диареей (поносом), длительная, более 48 часов задержка кала в кишечнике, носит название запоров.

По внешнему виду каловые массы могут различаться. Плотные каловые массы типичны для запоров, жидкие - для диареи. Кал может содержать непереваренные кусочки пищи. При большом содержании жира он становится серым, блестящим, мазевидным. Светлые пенистые (вследствие содержания газов) испражнения без примеси слизи и крови являются признаком бродильной диспепсии, а жидкие темно-коричневые испражнения с острым гнилостным запахом - гнилостной диспепсии. Черный неоформленный мазевидный кал (вследствие присутствия в нем сернистого железа, метгемоглобина и гематина), наблюдается у больных с пищеводными,

желудочными или высокими кишечными кровотечениями. Такой кал носит названия "мелена".

В зависимости от локализации поражения формируется своеобразный симптомокомплекс. Для поражения тонкого кишечника характерна связь диареи с приемом пищи, наличие в испражнениях непереваренных кусочков пищи. В ряде случаев, больные с хроническим энтеритом отмечают бурные позывы к дефекации вскоре (30-40 мин) после еды. При этом испражнения обильные (полифекалия), имеют жидкую или кашицеобразную консистенцию, светло-желтого цвета, содержат кусочки непереваренной пищи. В таких случаях возникновение диареи связано с гастроинтестинальным рефлексом, когда заполнение желудка пищей вызывает резкое усиление моторики тонкого кишечника. Для поражения толстого кишечника характерно чередование запоров и поносов. Поносы, возникающие у ряда больных сразу после еды, объясняются гастроцекальным рефлексом. Каловые массы содержат примесь слизи. Больные ощущают недостаточное опорожнение кишечника после акта дефекации. При поражении преимущественно дистального отдела толстой кишки, особенно при вовлечении в патологический процесс заднего прохода, появляются тенезмы - частые позывы на дефекацию, с выделением небольших количеств кала и газов. Возможны ложные позывы на дефекацию, при этом каловых масс почти нет, выделяется лишь небольшое количество газов и слизи (так называемый "ректальный плевок").

Метеоризм

Метеоризм ощущение пучения, вздутия, тягостного распирания живота. Развивается вследствие усиленного газообразования в кишечнике, обусловленного употреблением с пищей растительной клетчатки и крахмала, легко подвергающихся процессам брожения (горох, бобы, капуста и др.).Метеоризм наиболее выражен во второй половине дня на высоте кишечного пищеварения. Часто сопровождается болями в области сердца,

сердцебиением, иногда пароксизмальной тахикардией (кишечно-кардиальный рефлекс).

Боли в животе

Общая характеристика болей при заболеваниях кишечника.

Боли в животе при заболеваниях кишечника не являются ведущим симптомом за исключением острой хирургической патологии, но наблюдаются довольно часто.

Локализация. При поражении тонкого кишечника боли чаще локализуются вокруг пупка, а при хронических колитах - в боковых отделах живота и подвздошной области. Острые боли в левой нижней части живота появляются при кишечной непроходимости, при воспалении сигмовидной кишки (сигмоидит). Боли в промежности, особенно в момент дефекации, в сочетании с наличием крови в кале характерны для заболевания прямой кишки (проктит, рак).

Характер. Боли могут быть разнообразные: тупые, ноющие, иногда схваткообразные (спастического типа), распирающие.

Ноющие боли типичны для воспалительных заболеваний кишечника. Они носят постоянный характер, усиливаются при напряжении от кашля или при тряской езде, не уменьшаются после дефекации.

При нарушении моторики кишечника боли носят приступообразный характер, чаще локализуются вокруг пупка, уменьшаются или исчезают после отхождения газов, дефекации, применение тепла и спазмолитических средств.

Общими признаками кишечных болей, позволяющими отличать их от желудочных, являются:

- отсутствие строгой связи с приемом пищи; исключением является воспалительный процесс в поперечной ободочной кишке (трансверзит), при котором боли в животе возникают тотчас после приема пищи; патогенез болей в данном случае связан с рефлекторными перистальтическими

сокращениями поперечной ободочной кишки при поступлении пищи в желудок;

- тесная связь болей с актом дефекации; они могут возникать до, во время и редко после опорожнения кишечника;
- облегчение болей после дефекации или отхождения газов.

Кишечные кровотечения

Кишечные кровотечения чаще всего возникают при язвенном поражении органов пищеварительной системы. Они могут наблюдаться при опухолях, протозойных и гельминтных инвазиях, острых инфекционных заболеваниях (брюшной тиф, бациллярная дизентерия), при тромбозе сосудов брыжейки, язвенном неспецифическом колите и др. Мелена (черный "дегтеобразный" кал) указывает на кровотечение из пищевода, желудка или верхних отделов тонких кишок. Наличие алой крови свидетельствует о кровотечении их нижних отделов кишечника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Тошнота, отрыжка воздухом, металлический привкус во рту возникают при нарушении моторики кишечника.

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Сужение круга интересов, мнительность, канцерофобия, раздражительность, эмоциональная слабость, недомогание, снижение работоспособности, ухудшение памяти, головные боли, головокружение имеют ложное происхождение. В их возникновении играют роль нарушение высших вегетативных регуляторных процессов, эндогенная интоксикация, нарушение всасывания микроэлементов, витаминов, белка, жиров и углеводов.

3.1.3 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Начало болезни: острое начало с повышением температуры, присоединение тенезмов, слизи и крови в кале является признаком острой

дизентерии. Постепенное начало, без резкой боли, повышения температуры, учащения стула с примесью крови характерно для острого недизентерийного энтероколита.

Характер течения болезни: рецидивирующее течение с ремиссиями различной продолжительности характерно для хронического энтерита, постдизентерийного колита; при колитах алиментарной этиологии болезнь протекает монотонно.

Причины обострений: при хроническом энтерите, колите обострения связаны с нерегулярным питанием, употреблением грубой, острой, раздражающей, недоброкачественной, однообразной пищей с высоким содержанием крахмала, либо жиров, либо углеводов.

Изменение характера болей, характера течения заболевания свидетельствует о присоединении осложнений.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Уточнить факторы, способствующие развитию заболевания:

- характер питания - нерегулярный прием пищи, однообразное, преимущественно углеводистое или белковое питание, обедненное витаминами и растительной клетчаткой; частое употребление трудно переваримой и острой пищи, злоупотребление алкоголем,
- длительное употребление лекарственных средств, повреждающих кишечник (салицилаты и др. нестероидные противовоспалительные препараты, цитостатики, антибиотики.),
- пищевая аллергия,
- ионизирующее облучение.

Перенесенные заболевания: острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез. пищевые токсикоинфекции), паразитарные или глистные инвазии, дисбактериоз кишечника, различные заболевания органов пищеварения (желудка, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря).

Профессиональнй анамнез: интоксикация промышленными ядами

3.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.2.1 ОБЩИЙ ОСМОТР

При хронических прогрессирующих заболеваниях кишечника обращает на себя внимание сухая, шелушащаяся, бледная или сероватого цвета кожа, тургор и эластичность ее снижены, пигментные пятна на лице, шее, тусклые, ломкие ногти, легко выпадающие волосы.

При легком течении болезни существенных изменений может не наблюдаться.

3.2.2. ОСМОТР ЯЗЫКА

Обложенный серовато-белым налетом язык характерен для хронического энтерита и колита, при выраженном синдроме мальабсорбции язык малиново-красный, потрескавшийся, сосочки атрофированы (лакированный язык).

3.2.3 ОСМОТР ЖИВОТА

При осмотре живота обращают внимание на форму и вид передней брюшной стенки. Вздутый ассиметричный живот характерен для непроходимости кишечника. Общее вздутие живота обусловлено метеоризмом (бродильная или гнилостная диспепсия).

3.2.4 ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА

Пальпация живота проводится по методу Образцова-Стражеско. Цель ее определить степень напряжения брюшной стенки, наличие ее болезненности в отдельных участках, прощупать уплотнения, грыжевые отверстия, расхождения мышц брюшной стенки, расположение органа, состояние его стенок, их поверхность, объем, диаметр, плотность, определить их подвижность и смещаемость (табл. 4).

Таблица 4

Нормативные пальпаторные характеристики

Объект пальпации	Частота прощупыва	Характеристика органа

	ния органа	
Сигмовидная кишка	Более 90%	Гладкий, плотноватый, б/бол, легко смещаем цилиндр, размером около 2.5-3см. При пальпации урчание не определяется.
Слепая кишка	80%	Кишка мягкой эластической консистенции, б./бол, разм 3-5см. Поверхность ее гладкая, при пальпации – урчит.
Поперечно-ободочная	60-70%	Кишка мягкой эластической консистенции, б/бол, легко смещается, не урчит
Восходящий и нисходящий отделы ободочной к-ки	45-50%	Кишки пальпируются в виде толстого, б/бол эластического цилиндра, размером 4-6 см, без урчания.

При пальпации выявляются следующие патологические симптомы:

- Вздутие живота, преимущественно в центральных отделах (при выраженном метеоризме) или западение в различных отделах живота (при выраженной диарее)
- Симптом Образцова - громкое урчание при пальпации слепой кишки,
- Симптом Герца - ощущение плеска при пальпации слепой кишки;
- Урчание при пальпации терминального отрезка подвздошной кишки;
- Спастические сокращения терминального отрезка подвздошной кишки;
- Точке Поргеса - локальная болезненность слева и выше пупка на уровне XII грудного и I поясничного позвонка;
- Точке Штернберга 1 - болезненность в илеоцекальной области.
- Точке Штернберга 2 -болезненность выше пупка справа на уровне II поясничного позвонка.

- При проведении глубокой скользящей пальпации живота по Образцову-Стражеско выявляются болезненность и уплотнение либо всего толстого кишечника, либо преимущественно одного его отдела.
- Зона кожной гиперестезии (зоны Захарьина-Геда). Эти зоны расположены в подвздошных и поясничной областях (болезненность при собирании кожной складки).
- При остром воспалении брюшины (в том числе и местном), положительный симптом Щеткина-Блюмберга).

3.2.6. ПЕРКУССИЯ ЖИВОТА

Перкуссия живота должна быть тихой. Она имеет целью выявить зоны болезненности.

При легкой перкуссии живота иногда более четко выявляются участки болезненности и распространенности воспалительного процесса, чем при пальпации.

Притупление перкуторного звука отмечается над опухолями и воспалительными инфильтратами в брюшной полости. Полная тупость определяется при скоплении свободной жидкости (асците).

Громкий тимпанический звук может свидетельствовать о метеоризме. Исчезновение перкуторной тупости над областью печени наблюдается при наличии воздуха в брюшной полости, например, при перфорации кишечника.

3.2.7 АУСКУЛЬТАЦИЯ ЖИВОТА

Имеет значение для оценки активности перистальтики кишечника. При парезе кишечника шумы при аускультации не выслушиваются. При скоплении газов кишечные шумы усиливаются. Громкое урчание иногда выслушивается во время ускоренного движения кишечного содержимого при усиленной перистальтике, а также над местом сужения кишки, вследствие ее сдавления опухолью или внутрибрюшным лимфоузлом.

3.3 ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.3.1 КОПРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Клиническое копрологическое исследование (копрограмма) имеет большое значение в диагностике заболеваний кишечника. При исследовании обращают внимание на консистенцию, запах, цвет, реакцию, количество мышечных волокон, перевариваемой клетчатки, крахмала, жира, мыл, наличие слизи и крови.

В норме: количество суточного кала 100-250г

- реакция кала - слабощелочная или нейтральная
- умеренное количество измененных волокон
- капельки нейтрального жира
- кристаллы жирных кислот и мыла в незначительном количестве
- крахмал в незначительном количестве
- клетчатка неперевaримая в умеренном количестве

Количество. Во многом зависит от количества, характера принятой пищи и от качества переваривания пищевых масс. Так пища, богатая белками ведет к уменьшению количества кала, а растительная пища - к увеличению. При недостаточной активности ферментов или их отсутствии непереваренные пищевые массы значительно увеличивают количества кала.

Консистенция и форма. Нормальный кал имеет колбасовидную форму и однородную плотную консистенцию. При запорах вследствие избыточного всасывания воды кал становится плотным. Форма "овечьего кала" указывает на спастическое состояние толстых кишок. При усилении перистальтики из-за недостаточного всасывания воды кал становится неоформленным, кащицеобразным или жидким. Мазевидная консистенция указывает на присутствие в нем большого количества жира.

Запах. В норме запах кала неприятный, но не резкий. Более резкий запах бывает при белковой пище, а при молочно-растительной - менее резкий.

Особенно резкий зловонный запах кал приобретает при гнилостной диспепсии. При усилении бродильных процессов в кишечнике каловые массы приобретают кислый запах. При энтеритах запах каловых масс практически отсутствует.

Цвет. Цвет обусловлен наличием стеркобилина, а также меняется в зависимости от характера пищи, лекарственных препаратов и от патологических примесей.

Коричневая окраска наблюдается при смешанной или мясной пище, светло-желтая - при молочной диете. Черный "дегтеобразный" кал указывает на кровотечение из желудка или верхних отделов тонких кишок. Глинистая окраска указывает на частичное или полное прекращение поступления желчи в кишечник (ахолия).

Реакция. Обычно кал слабощелочной реакции. Реакция его зависит главным образом от жизнедеятельности микробной флоры кишечника. Резкощелочная реакция свидетельствует о преобладании гнилостных процессов, которые наблюдаются при ахлоргидрии и при панкреатитах из-за выраженной креатореи. Кислая реакция кала бывает при преобладании углеводистой пищи, усилении процессов брожения и избыточном образовании жирных кислот.

Белок Наличие в кале сывороточного белка определяется методом Трибуле. В норме растворимый белок в кале не содержится, появляется при воспалительных процессах и изъязвлении стенки кишечника, а также при ускоренной эвакуации их кишечника.

При различных патологических состояниях кал может содержать:

- переваренные и непереваренные мышечные волокна, появляющиеся при состояниях, сопровождающихся ахилией, нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы (креаторея), а также при гнилостной диспепсии и ускоренной эвакуации пищевой массы из кишечника,

- большое количество нейтрального жира, жирных кислот и мыл (стеаторея) отмечается при нарушении поступления желчи в кишечник, при нарушении всасывания в тонком кишечнике и при нарушении внешнесекреторной функцией поджелудочной железы,
- появление крахмала в большом количестве (амилорея) встречается при ускоренной эвакуации из тонкого кишечника, при бродильных процессах, нарушении внешнесекреторной функции поджелудочной железы,
- обнаружение в кале большого количества волокнистой соединительной ткани чаще указывает на желудочную ахилию или на ускоренную эвакуацию из кишечника,
- появление в большом количестве неперевариимой клетчатки бывает при состояниях, сопровождающихся ахилией, а также при диарее любой этиологии и при дисбактериозе.

3.3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ

Исследование бактериальной флоры позволяет выявить дисбактериоз - уменьшение количества бифидобактерий, лактобактерий, увеличение количества гемолитических и лактозонегативных эшерихий, патогенного стафилококка, протея, гемолитического стрептококка.

3.3.3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИШЕЧНИКА

При рентгеноконтрастном исследовании кишечника можно определить тонус, перистальтику, гаустрацию, сужение просвета кишечной трубки, расширение, смещение, удлинение петель кишок, наличие спаек, дефектов наполнения, уровней жидкости, скопление газов

3.3.4. ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА (РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ)

Выявляет воспалительные изменения слизистой оболочки, эрозии, усиление или обеднение сосудистого рисунка, атрофию - при длительном течение воспалительного процесса

3.4 СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА

1. СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

Возникает либо из-за нарушения нормальных процессов переваривания и всасывания пищи в тонком кишечнике вследствие развития:

а) мальдигестии;

б) мальабсорбции**;**

либо из-за нарушения функций толстого кишечника вследствие:

а) бродильной диспепсии;

б) гнилостной диспепсии

либо вследствие нарушения эвакуации из кишечника;

а) ускоренная эвакуация из толстого кишечника;

б) замедленная эвакуация из толстой кишки;

в) кишечная непроходимость;

2. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

3. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

4. АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИЙ

5. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ

3.4.1 СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

Кишечная диспепсия является ведущей при заболеваниях кишечника и возникает из-за нарушения нормальных процессов переваривания, всасывания пищи в кишечнике либо нарушения его моторной функции.

В зависимости от механизма возникновения синдром кишечной диспепсии бывает различным: при нарушении переваривания в тонком кишечнике развивается *мальдигестия,* при нарушении всасывания - *мальабсорбция*; при нарушении переваривания белков - *гнилостная диспепсия;* при нарушении переваривания углеводов - *бродильная диспепсия*; при нарушении эвакуации развиваются синдромы *ускоренной эвакуации из тонкого кишечника, замедленной эвакуации из толстой кишки, кишечная непроходимость.*

С клинических позиций удобно нарушения со стороны тонкого кишечника, патогенетически обусловленные мальдигестией и мальабсорбцией рассматривать в рамках *общего энтерального синдрома.*

МАЛЬДИГЕСТИЯ **-** нарушение переваривания пищевых веществ вследствие дефицита пищеварительных ферментов (ферментопатии). В основе возникновения нарушения пишеварения лежит генетически обусловленная или приобретенная недостаточная выработка пищеварительных ферментов тонкой кишки.

Выделяют три формы синдрома мальдигестии, проявляющегося нарушением преимущественно:

1. полостного пищеварения,
2. пристеночного (мембранного),
3. внутриклеточного пищеварения.

Кроме того, существуют смешанные формы недостаточности пищеварения.

Недостаточность полостного пищеварения развивается вследствие: снижения секреторной функции желудка, кишечника, поджелудочной железы, желчеотделения; нарушение двигательной функции желудочно-кишечного тракта вследствие застоя химуса, спазма, стеноза или ускоренной эвакуации, перенесенных кишечных инфекций; изменения кишечной микрофлоры; алиментарных нарушений (переедания, несбалансированного питания).

Недостаточность пристеночного пищеварения - нарушение окончательного гидролиза (расщепления) пищевых продуктов на мембранах кишечных ворсинок. Морфологическим субстратом являются воспалительные, дистрофические и склеротические изменения в слизистой оболочке тонкой кишки.

Возникает: при хроническом энтерите, энтеропатиях, болезни Уиппла, болезни Крона и др.

Недостаточность внутриклеточного пищеварения развивается вследствие генетически обусловленной или приобретенной непереносимости дисахаридов. Причинами последней могут быть заболевания тонкой кишки, желудка, поджелудочной железы, печени. В патогенезе существенное значение имеет усиление процесса брожения, вследствие поступления перисщепленных дисахаридов в толстую кишку и активация микробной флоры.

МАЛЬАБСОРБЦИЯ - нарушение всасывания из тонкой кишки пищевых веществ, приводящее к выраженному расстройству питания больного.

В основе развития этого синдрома лежат морфологические изменения слизистой оболочки тонкой кишки и ферментных систем. Нарушение всасывания (мальабсорбция) может развиться как самостоятельно, так и вследствие предшествующего повреждения всасывательной поверхности тонкой кишки различного происхождения: резекции тонкой кишки, токсических и радиационных повреждений, воспалительных и аутоимунных заболеваний.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МАЛЬДИГЕСТИИ И МАЛЬАБСОРБЦИИ (ОБЩИЙ ЭНТЕРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ)

Кишечные (местные) симптомы

- Ведущий и ранний симптом - поносы. В течение дня происходит 2-3 дефекации (иногда больше), с выделение большого количества кашицеобразного кала.
- Метеоризм, обусловленный повышенным газообразаванием, нарушением абсорбции и удалением газов. Вздутие живота и урчание усиливается во вторую половину дня и ночью. Характерны отрыжка и неприятный вкус во рту.
- В копрограмме: стеаторея (наиболее ранний и частый симптом), амилорея, креаторея (табл.5).

Таблица 5

Копрограмма при стеаторее, амилорее, креаторее

	Стеаторея	Амилорея	Креаторея
Количество	до 1000 г		
Консистенция	Мазевидная	Кашицеобр	Кашицеобр
Цвет	Серо-желтый	Желтый	Темно-кор
Запах	Зловонный	-	-
Реакция	Щелочная, кислая	Кислая	Щелочная
Мышечные волокна непереваренные	-	_	+++
Соединител ткань	-	-	+-
Нейтральные жиры	+++	-	+-
Жирные кислоты	+++	-	+-
Мыла	+	+-	+-
Переваримая клетчатка	+-	+++	++
Крахмал	-	+++	-
Йодофильная флора	-	++	-
Аммиак	-		+++

Общие (некишечные) симптомы

В связи с развитием мальдигестии и мальабсорбции нарушаются все виды обмена веществ (жировой, углеводный, белковый, минеральный, а также обмен витаминов).

1. Расстройства белкового обмена с последующей симптоматикой: падением массы тела, атрофией мышц, появлением отеков, в крови гипопротеинемия.
2. Расстройства жирового обмена характеризуются: снижением массы тела, нарушением переваривания и всасывания жира, гипохолестеринемией, дефицит жиророрастворимых витаминов.

3. Расстройства углеводного обмена проявляются бродильной кишечной диспепсией, наклонностью к снижению содержания в крови глюкозы.
4. Расстройства минерального обмена выражаются: гипокальциемией (судороги, онемение губ, пальцев стоп и кистей, остеопороз), гипокалиемией (мышечная слабость, снижение моторики кишечника, экстрасистолия).
5. Дефицит железа приводит к развитию железодефицитной гипохромной анемии; сухости кожи и слизистой оболочек; изменению ногтей, ломкости и выпадению волос; извращению вкуса и обоняния.
6. Нарушение обмена витаминов различной степени имеет место практически у всех больных.

БРОДИЛЬНАЯ И ГНИЛОСТНАЯ ДИСПЕПСИЯ

Бродильная диспепсия - форма кишечной диспепсии возникающая в связи с нарушением функции толстой кишки, и развитием бродильных процессов вследствие нарушения переваривания углеводов, а также при избытке их в питании.

Гнилостная диспепсия - форма кишечной диспепсии, возникающая в связи с нарушением функции преимущественно толстого кишечника, вследствие нарушения переваривания белков и развития гнилостных процессов, либо является следствием синдрома мальдигестии.

Причины возникновения, основные клинические и копрологические симптомы бродильной и гнилостной диспепсии представлены в таблице 6

Таблица 6

Клиническая картина бродильной и гнилостной диспепсии

	Бродильная диспепсия	Гнилостная диспепсия
Причины	Нарушение переваривания углеводов, избыток в питании	Нарушение переваривания белков

Заболевания	Колиты, энтериты, дисбактериоз	Колиты, энтериты, дисбактериоз, атрофический гастрит, рак желудка
Клинические проявления	метеоризм, тошнота, поносы 2-5 раз в сутки, схваткообразные боли в животе, ослабевающие после отхождения газов	Поносы 2-4 раза в сутки чередуются с запорами, метеоризм, зловонные газы, боли в животе постоянные, реже коликообразные
Копрограмма		
Количество	более 200-500г	+++
Консистенция	Кашицеобразный пенистый	Кашицеобразный
Цвет	Желтый	Темно-коричневый
Запах	-	Зловонный
Реакция	Резко кислая	Щелочная
Мышечные волокна	+	+
Соед. ткань	+	+
Жирные кислоты	+	+
Мыла	+	+
Крахмал	++	+
Переваримая клетчатка	+	+++
Йодофильная флора	+++	+
Количество	+	+++

аммиака		

НАРУШЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ ИЗ КИШЕЧНИКА проявляется в ускорении или замедлении перистальтики и чередовании этих процессов, а также в нарушении маятникообразных движений кишечника.

Проявляется в виде:

1. Ускоренной эвакуации.
2. Замедленной эвакуации.
3. Кишечной непроходимости.

Ускоренная эвакуация развивается в результате ускорения перистальтики. Пищевая кашица продвигается по кишечнику быстрее, развивается понос.

Причины:

1. Воспалительные изменения в толстом кишечнике (повышается возбудимость рецепторов кишечной стенки) - энтерит, дизентерия, холера и т.д.
2. Действие на стенку толстой кишки раздражителей: непереваренной пищи (при ахилии, при панкреатической недостаточности, при синдроме мальдигестии), продуктов брожения и гниения, токсических веществ, аллергенов. Ускоренная перистальтика в данном случае имеет защитное значение.
3. Повышение возбудимости центра симпатической иннервации, которая активирует моторику кишечника.
4. Рефлекторное ускорение эвакуации в результате гастро-цекального рефлекса.

Копрологические изменения при ускоренной эвакуации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Копрологические изменения при ускоренной эвакуации из различных отделов кишечника

	Из тонкого кишечника	Из толстого кишечника	Из тонкого и толстого кишечник
Количество	++	+++	+++
Консистенция	Жидкий	Кашицеобразный	Жидкая
Цвет	Желтый, светло-коричневый	Желтый, светло-коричневый	Зеленоватый
Реакция	Слабо-щелочная	Слабо-кисл, нейтр	Резко-щелочная
Мышечные волокна	++	+	+
Неперевариимые мышечные волокна	+	+++	++++
Жирные кислоты	++	+	+
Нейтральный жир	+++	+	+
Мыла	++	+	+
Крахмал	++	+++	+++
Йодофил флора	++	+++	+++
Переваримая клетчатка	+++	+	+++

Замедленная эвакуация из толстого кишечника - проявляется в виде атонических или спастических запоров.

Причины:

1. Алиментарные факторы (скудное питание, бедное клетчаткой, недостаток в диете солей калия и кальция).
2. Чрезмерное переваривание пищевых масс в желудке (при повышенной кислотности желудочного сока, при синдроме ацидизма)

3. Изменения в кишечной стенке у стариков или при ожирении.

4. Авитаминоз.

5.Врожденные нарушения перистальтики кишечника (при болезни Гиршпрунга).

При длительных запорах страдает кишечное пищеварение, так как снижается отделение кишечного сока и тормозится активность его ферментов, может развиться гнилостная микрофлора (синдром гнилостной диспепсии). Это ведет к кишечной интоксикации.

Основные клинические признаки: повышенная утомляемость, вялость, плохой аппетит неприятный вкус во рту, тошнота, иногда развивается тахикардия и головокружения. Язык часто обложен, живот вздут, кожные покровы при длительных запорах могут быть желтоватые с коричневым оттенком. После устранения запоров, состояние нормализуется.

Характер испражнений при запорах

При атоническом запоре: Каловые массы обильные, оформленные, колбасовидные. Нередко начальная порция очень плотная, большего, чем в норме, диаметра, конечная -полуоформленная. Дефекация осуществляется с большим трудом, очень болезненна.

При спастическом запоре: Количество кала уменьшено, консистенция твердая, ("овечий кал"), запах гнилостный, реакция щелочная, остатки непереваренной пищи в нормальном количестве. Запоры сопровождаются метеоризмом, чувством давления, распирания, спастической болью в животе

КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ **-** является синдромом острого живота и рассматривается в разделе хирургической патологии

3.4.2. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Функциональное расстройство толстой кишки с нарушением моторной и секреторной функций, длительностью свыше 3 месяцев.

Основные клинические признаки:

1 Боли в животе - локализуются около пупка или внизу живота. Имеют различную интенсивность, от незначительно ноющих до весьма выраженной кишечной колики. Как правило, боли уменьшаются или исчезают после дефекации или отхождения газов. Важным отличительным признаком является отсутствие болей и других симптомов ночью.

2 Нарушение стула выражается в появлении диареи или запора. Диарея часто возникает внезапно после еды, иногда в первой половине дня. Характерно отсутствие полифекалии (количество кала менее 200г за сутки, при запорах он напоминает овечий). Кал часто содержит слизь. У многих больных бывает ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации.

3. Метеоризм - один из характерных признаков, обычно усиливается к вечеру. Как правило, вздутие живота нарастает перед дефекацией и уменьшается после нее. Довольно часто метеоризм имеет локальный характер.

Лабораторно-инструментальные исследования:

- Копрограмма: большое количество слизи или слизистых пленок и лент, в которых при микроскопии иногда обнаруживаются эозинофилы.
- Эндоскопическии - изменений не обнаруживается.
- При рентгенологическом исследовании могут выявляться признаки дискинезии асимметричность и неравномерность сокращений толстой кишки, чередование спастически сокращенных и расширенных участков кишки.

3.4.3 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Различают следующие типы болей в животе:

- спастические
- вследствие метеоризма
- мезентериальные
- вследствие ганглионита
- прямокишечной колики
- смешанного характера

Спастические боли обусловлены сокращениями тонкого или толстого кишечника, носят приступообразный характер, и локализуются над участком спазма.

Боли вследствие метеоризма - обычно постоянного характера, связаны с раздутием кишки газами, уменьшаются после отхождения газов и дефекации.

Мезентериальные боли обусловлены развитием неспецифического мезаденита. Эти боли носят постоянный характер, не связаны с едой, не купируются холинолитиками, спазмолитиками, не исчезают после дефекации и отхождения газов. Боли располагаются по ходу брыжейки тонкой кишки.

Боли вследствие ганглионита. При хроническом энтерите возможно вовлечение в патологический процесс ганглиев вегетативной нервной системы. В этом случае боли носят своеобразный жгучий характер, они постоянные, не уменьшаются после дефекации и отхождения газов, а также после применения спазмолитиков.

Прямокишечная колика, или так называемые тенезмы - они проявляются частыми и болезненными позывами на дефекацию с чувством судорожного сокращения кишки и сфинктера. Дефекация при этом не происходит, иногда выделяются комочки слизи (ректальный плевок).

Боли смешанного характера обусловлены сочетанием причин, вызывающих боли в животе. Чаще всего это сочетание спастических болей и болей, обусловленных метеоризмом.

3.4.4 АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

При длительном течении хронического колита развивается астеноневротический синдром. Больные жалуются на слабость, быструю утомляемость, головную боль, снижение работоспособности, плохой сон.

3.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНТЕРИТ- полиэтиологическое заболевание тонкого кишечника, характеризуюшееся развитием воспалительно-дистрофических

процессов, дисрегенераторными изменениями, атрофией слизистой оболочки тонкой кишки различной степени, нарушением всех функций тонкого кишечника, в первую очередь всасывательной и пищеварительной.

Основные синдромы:

1. Синдром кишечной диспепсии:
   энтеральный синдром (мальдигестия, мальабсорбция)
2. Болевой синдром
3. Клинико-анамнестический

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ - хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся развитием воспалительно-дистрофических, а при длительном существовании - атрофических изменений слизистой оболочки.

Основные синдромы:

1. Синдром кишечной диспепсии:
   а) бродильная диспепсия
   б) гнилостная диспепсия
   в) ускоренная эвакуация из толстой кишки
   г) замедленная эвакуация из толстой кишки
2. Болевой синдром
3. Синдром астеноневротический
4. Клинико-анамнестический

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ (НЯК) - заболевание неизвестной этиологии, характерезующееся развитием некротизирующего воспалительного процесса слизистой оболочки толстого кишечника с образованием язв, геморрагий и гноя.

Основные синдромы:

1. Синдром кишечной диспепсии:
   а) бродильная диспепсия
   б) гнилостная диспепсия

в) ускоренная эвакуация из толстой кишки

2. Болевой синдром
3. Анемический
4. Интоксикационно-воспалительный
5. Синдром астеноневротический
6. Синдром системных проявлений: полиартрит; узловатая эритема; поражение кожи (пиодермия, очаговый дерматит); поражение глаз (ирит, ириидоциклит, кератит); поражение печени (жировая дистрофия, хронический активный гепатит, цирроз печени); поражение слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит, глоссит, язвенный стоматит); нефротический синдром; аутоиммунный тиреоидит; аутоиммунная гемолитическая анемия.
7. Клинико-анамнестический

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА **-** функциональные расстройства толстой кишки, продолжающиеся свыше 3 месяцев.

Основные синдромы:

1. Синдром раздраженной толстой кишки.
2. Болевой синдром
3. Синдром астеноневротический

ГЛАВА 4
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

4.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

4.1.1. ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

- Боли в животе
- Диспепсические жалобы (отрыжка, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, нарушение стула)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Локализация и иррадиация. Боли, как правило, локализуются в эпигастральной области или в левом подреберье. При остром панкреатите локализуются в верхней половине живота и нередко носят опоясывающий характер. При поражении опухолевым или воспалительным процессом головки поджелудочной железы боли локализуются в правом подреберье, иррадиируя в спину в область VI-XI грудных позвонков; при распространении воспалительного процесса на тело поджелудочной железы боли локализуются в эпигастральной области. При поражении хвоста поджелудочной железы боли локализуются в левом подреберье, при этом боль иррадиирует в влево и вниз от VI грудного до I поясничного позвонка. При тотальном поражении поджелудочной железы боль локализуется во всей верхней половине живота и носит опоясывающий характер. Боли усиливаются при положении больного на спине вследствие давления на солнечное сплетение и уменьшаются в положении сидя с наклоном туловища вперед. При выраженном болевом

синдроме больные принимают вынужденное положение -сидят с согнутыми в коленях ногами, приведенными к животу.

Характер и продолжительность. Приступообразные боли типа желчной колики, возникающие через 3-4 часа после приема пищи (особенно жирной), характерны для калькулезного панкреатита. Нередко боли настолько интенсивны, что снимаются лишь после применения спазмолитических препаратов и даже наркотиков.

Особенно острые боли отмечаются при остром панкреатите. Возникают они внезапно и продолжаются от нескольких часов до нескольких дней. Значительная интенсивность болевых ощущений и бурное их начало при остром панкреатите объясняются внезапно наступающей закупоркой главного выводного протока поджелудочной железы в результате спазма и воспалительного отека с последующим резким повышением давления в мелких протоках поджелудочной железы и раздражением солнечного сплетения.

При хроническом панкреатите наблюдаются боли ноющего характера различной интенсивности. Боли появляются через 3-4 часа после еды, чаще после обеда и нарастают к вечеру,

При опухолях поджелудочной железы боли отмечаются высокой интенсивностью и продолжительностью.

Что усиливает или облегчает боль. Основную роль в усилении боли при панкреатитах играет качество пищи: обильный прием жирной пищи, прием алкогольных напитков. Голодание облегчает боль, поэтому многие больные мало едят. Боли также уменьшаются при применение холода (пузырь со льдом) на область ПЖ, а также в коленно-локтевом положении или сидя с наклоном вперед.

ДИСПЕСИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ

Тошнота и рвота чаще сопутствуют острому панкреатиту и носят рефлекторный характер. При хроническом панкреатите и опухолях поджелудочной железы диспептические явления связаны с нарушением

ферментативной деятельности поджелудочной железы. Тошнота может быть постоянной и мучительной. Рвота как правило не приносит облегчения.

Ситофобия **-** боязнь спровоцировать боль и диспептические явления. из-за плохой переносимости большого ассортимента блюд и продуктов, приводит к значительным ограничением в еде и, как следствие, к значительной потере в весе.

Снижение аппетита или анарексия - в фазе обострения больные с хроническим панкреатитом жалуются на снижение аппетита; значительное снижение вплоть, до отвращения к пищи, отмечается при тяжелом течении хронического панкреатита

Метеоризм возникает из-за нарушения внешней секреции поджелудочной железы

Поносы с обильными жидкими блестящими (“жировой стул”) и зловонными испражнениями возникают из-за нарушения внешней секреции поджелудочной железы. Нарушение кишечного пищеварения приводит к быстрому похуданию больного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Желтуха механического типа, прогрессирующая, темно-бурой, зеленоватой окраски, сопровождающаяся резким кожным зудом и геморрагиями, характерна для рака головки поджелудочной железы, так как опухоль сдавливает проходящий в ней конечный отрезок общего желчного протока, препятствуя оттоку желчи. Желтуха может появляться также при склерозе головки поджелудочной железы как следствие хронического панкреатита.

При нарушении внутренней секреции поджелудочной железы (ПЖ) появляются жалобы характерные для сахарного диабета: жажда, полиурия, полидипсия, зуд кожи.

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: слабость, снижение трудоспособности, быстрая утомляемость, повышение температуры.

4.1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Начало болезни: Острое начало с повышением температуры, сильными болями, рвотой характерно для острого панкреатита. Постепенное начало, постоянные боли различной интенсивности, нарушение стула - для хронического панкреатита. При присоединение желтухи можно думать о псевдотуморозной форме хронического панкреатита (ХП) или об опухоли головки ПЖ.

Характер течения болезни: Волнообразное рецидивирующее течение характерно для рецидивирующей форме ХП; постоянные боли, метеоризм, неустойчивый стул - для ХП с постоянными болями

Причины обострения: - погрешности в еде, злоупотребление алкоголем, длительно протекающий холецистит.

Изменение характера болей, характера течения заболевания свидетельствует о присоединении осложнений

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Характер питания: обильный прием жирной и высококалорийной пищи, дефицит белка в диете.

Вредные привычки: злоупотребление алкоголем (прием 80-200мл. чистого алкоголя в день).

Сопутствующие заболевания: заболевания желчевыводящих путей; заболевания желудка и 12 п.к.; вирусные инфекции (эпидемический паротит, вирусный гепатит В); обменные и гормональные нарушения веществ (гиперпаратиреоз); травмы ПЖ, нарушение кровообращения в системе мезентериальных сосудов; токсические и аллергические воздействия, наследственная предрасположенность.

4.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.2.1 ОБЩИЙ ОСМОТР

Пониженное питание больного отмечается при длительном прогрессирующем течении хронического панкреатита или раке поджелудочной железы, кожа становится сухой, теряет эластичность, приобретает грязно-серый оттенок, появляется пигментация на коже лица и конечностях. Субиктеричная окраска кожи и слизистых оболочек мягкого неба и склер или их желтушность возникает при псевдотуморозной форме хронического панкреатита или опухоли головки ПЖ. Бледность кожных покровов с участками цианоза наблюдается при остром панкреатите в результате нарушений дыхания и кровообращения, развившихся вследствие тяжелой интоксикации.

4.2.2 ОСМОТР ЯЗЫКА

Отмечается сухость и обложенность языка, сглаженность и атрофия сосочков, появляется своеобразный неприятный запах, трещины и изъязвления в уголках рта (хейлит), афтомозный стоматит.

4.2.3 ОСМОТР ЖИВОТА

Живот нередко увеличен в объеме за счет метеоризма. В области живота, на груди и реже- на спине можно видеть четко ограниченные ярко-красные небольших размеров элементы, несколько возвышающиеся над поверхностью кожи, - симптом “красных капелек”, которые, однако, нельзя считать специфичными для хронического панкреатита а также коричневатая окраска кожи над областью поджелудочной железы. При внимательном осмотре изредка определяются атрофия подкожной жировой клетчатки в эпигастрии - в зоне, соответствующей проекции ПЖ на переднюю брюшную стенку (симптом Гротта).

4.2.4. ПАЛЬПАЦИЯ

При поверхностной пальпации живота у больного с острым панкреатитом отмечаются болезненность и напряжение мышц брюшного пресса в подложечной области, иногда в области левого подреберья или в месте проекции поджелудочной железы (симптом Керте).

При глубокой пальпации больных с хроническим панкреатитом и опухолью поджелудочной железы иногда можно пропальпировать ПЖ в виде плотного, неровного и слега болезненного тяжа. Определенное диагностическое значение могут иметь болезненные точки и зоны, выявляемые при пальпации в эпигастрии и в зоне расположения ПЖ, которые считаются характерными для хронического панкреатита.

Симптомы, отражающие вовлечение в патологический процесс головки ПЖ см рис. 1:

- болезненность в холедохопанкреатической зоне Шоффара, расположенной в эпигастральнии справа (в правом верхнем квандранте живота - кнутри от биссектрисы, разделяющей прямой угол, образованный двумя пересекающимися линиями: передней срединной линией живота и линией проведенной перпендикулярно к ней через пупок.
- Одновременно у тех же больных нередко определяется болезненность в точке Дежардена, которую находят на расстоянии 6 см от пупка на линии, мысленно проведенной от пупка к правой подмышечной впадине. Болезненность при пальпации в зоне Шоффара и в точке Дежардена выявляется чаще всего при холепанкреатите и псевдоопухолевой форме ХП, так как соответствует локализации головки ПЖ.
- При поражении тела ПЖ определяется болезненность при пальпации точки Мейо-Робсона, а также выявляется положительный «симптом поворота».
- Точка Мейо-Робсона расположена на границе наружной и средней трети линии, соединяющей пупок и середину левой реберной дуги.

  Положительный симптом поворота обозначает уменьшение болезненности в точке Мейо-Робсона при повороте больного на левый бок. Это объясняется тем, что желудок и кишечник, смещаясь, создают дополнительную «подушку» между ПЖ и рукой врача, что ведет к уменьшению боли. Боль, вызванная заболеванием желудка или кишечника, при этом усиливается

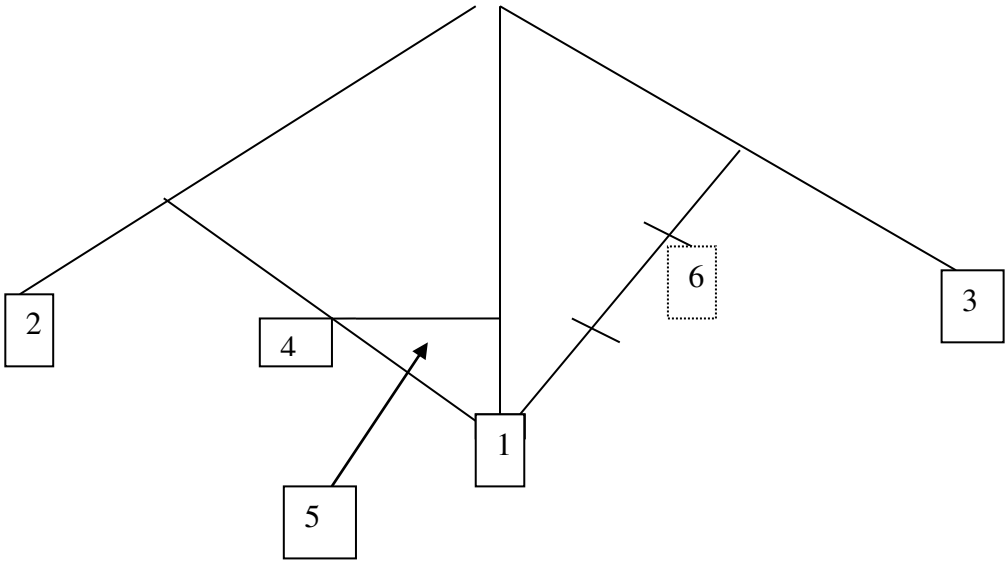


Рис 1. Болевые точки выделяемые у больных с хроническим панкреатитом

1 – пупок, 2,3 –- левое и правое подреберье, 4 - точка Дежердена,

5 – треугольник Шоффара, 6 – точка Мейо-Робсона

При поражении хвоста ПЖ обнаруживается болезненность в левом реберно-позвоночном углу (точка Мейо-Робсона II)

- Положительный симптом Кача – зона кожной гиперестезии в зоне кожной иннервации VIII- X го грудных сегментов, может быть единственным симптомом при раке хвоста ПЖ.

4.2.5 ПЕРКУССИЯ ПЖ мало информативна, даже при значительном увеличении ПЖ вследствие поликистоза или опухолей.

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.3.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Общий анализ крови- увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево, диспротеинемия, положительные острофазовые тесты, например, С-реактивный протеин – в крови при обострение хронического панкреатита.

- Повышение активности амилазы в крови (диагностическое значение для ХП имеет пятикратное увеличение данного показателя) и моче, трипсин, липаза и ингибитора трипсина в крови пи обострении ХП
- Увеличение в сыворотке крови билирубина, трансаминаз (АлАт, АсАТ), щелочной фосфотазы и ГГТП при наличии препятствия в области большого дуоденального соска или сдавения дистального отдела общего желчного протока уплотненной и сдавленной головки ПЖ.
- Изменения протеинограммы и уровня кальция в крови при хроническом калькулезном холецистите.

4.3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Изменение показателей панкреосекреции (ферментов, гидрокарбонатов, объема сока) при исследовании сока ПЖ до и после стимуляции секретином и панкреозимином.
- Исследования копрограммы: при внешнесекркторной недостаточности преобладает стеаторея, по мере прогрессировния присоединяются креаторея и амилорея
- Гипергликемия натощак и в течение суток; при проведении теста толерантности к углеводам выявляются нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет

4.3.3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Обзорная рентгенограмма брюшной полости (кальцинаты в проекции ПЖ)
- ФГДС с осмотром фатерового соска (исключает дуоденит)
- Компьютерная томография (КТ) позволяет выявить увеличение или уменьшение ее размеров, диффузное неравномерное накопление изотопа в ткани железы.
- УЗИ дает информацию о форме, величине, эхоструктуре ПЖ

- Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография выявляет изменения протоковой системы ПЖ и билиарной систеиы с цнлью определения локализации стенозов и обструктивных процессов.

4.4 СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ

Включает в себя комплекс симптомов (синдромов) патогенетически связанных с воспалительным отеком, аутолизом ткани поджелудочной железы и резорбцией панкреатических ферментов. К ним относятся:

- боли (болевой синдром)
- панкреатическая диспепсия (синдром панкреатической диспепсии)
- клинические и лабораторные симптомы острой фазы воспаления (sd воспалительной интоксикации)
- подпеченочная желтуха (sd подпеченочного холестаза)
- панкреатическая гиперферментемия и гиперамилазурия

2. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ

3. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ИНКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ

4.4.1 ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ

Развивается вследствие серозного воспаления ПЖ, гибели ацинозных клеток и разрастания соединительной ткани. Сопровождается развитием боли, панкреатической диспепсии, панкреатической гиперферментемией и гиперамилазурией, подпеченочной желтухи и симптомами острой фазы воспаления.

Боль возникает в результате: растяжение протоков поджелудочной железы при повышении в них давления; воздействие воспалительного процесса на рецепторный аппарат железы; ишемия ткани ПЖ вследствие отека или фиброза.

Боль появляется достаточно рано. При локализации воспалительного процесса в области головки ПЖ боли ощущаются в эпигастрии преимущественно справа, в правом подреберье, иррадиируют в область VI-XI грудных позвонков. При пальпации определяется болезненная точка Дежердена (см рис 1). При вовлечении в воспалительный процесс тела ПЖ боли локализуются в эпигастрии и при пальпации возникает болезненность в т.Мейо-Робсона-I (см рис 1). При поражении хвоста ПЖ - в левом подреберье, с иррадиацией в спину, определяется болезненность в т.Губергрица, т.Мейо - Робсона-II. При тотальном поражении ПЖ боль локализуется во всей верхней половине живота и носит опоясывающий характер.

Боль усиливается в положении лежа на спине, после приема жирной и жареной пищи, желчегонных средств.

Боль ослабевает в положении сидя, особенно при небольшом наклоне вперед. Голод, антациды, спазмолитики, М-холинолитики уменьшают боль (снимается спазм сфинктера Одди, нормализуется тонус двенадцатиперстной кишки).

Панкреатическая диспепсия

Сочетается (патогенетичеси связана) с синдромом внешнесекреторной недостаточности ПЖ. Достаточно характерна для ХП, особенно часто выражена при обострении или тяжелом течение заболевания. Диспептический синдром проявляется повышенным слюноотделением, отрыжкой воздухом или съеденной пищей, тошнотой, рвотой, потерей аппетита, отвращение к жирной пище, вздутием живота. Больные часто испытывают тошноту. Она бывает постоянной и мучительной, может быть связана с приемом или характером пищи. Боясь тошноты, больные значительно сокращают прием пищи или даже отказываются от еды. Наряду с тошнотой у части больных наблюдается рвота, обычно не приносящая облегчения.

В фазе обострения больные жалуются на снижения аппетита. Значительное снижение аппетита, вплоть до отвращения к пище, отмечается при тяжелом течении заболевания.

Панкреатическая гиперферментемия и гиперамилазурия

Специфический лабораторный признак воспалительно-деструктивного синдрома. Вследствие препятствия оттоку панкреатического сока и усиленной секреторной деятельности ацинарных желез происходит разрыв базальной мембраны ацинарных клеток с выходом в окружающую ткань ферментов. В крови и моче повышается уровень диастазы (амилазы).

Подпеченочная желтуха

Обусловлен отеком головки поджелудочной железы, увеличением железы (смотри в синдромах поражения печени).

Клинические и лабораторные симптомы острой фазы воспаления

- Слабость, лихорадка, артралгия.
- Увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево, диспротеинемия, положительные острофазовые тесты, например, С-реактивный протеин – в крови.

4.4.2. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ

Развивается вследствие уменьшения количества панкреатического сока и недостаточного содержания в нем ферментов (липазы, амилазы, трипсина).

Причины возникновения: острые и хронические панкреатиты, закупорка или сдавление протока железы, разрушение железы опухолью, неврогенное торможение функции поджелудочной железы (вагусная дистрофия, отравление атропином), дуодениты, сопровождающиеся уменьшением образования секретина, вследствие чего понижается секреция панкреатического сока, аллергическое поражение ПЖ. При нарушении внешней секреции страдает кишечное пищеварение (пристеночное и полостное).

Внешнесекреторная недостаточность представлена клиникой мальдигестии и мальабсорбции (описание синдромов кишечной диспепсии в разделе «Семиотика и синдромология заболеваний кишечника).

Ранним признаком внешнесекреторной недостаточности ПЖ является *стеаторея,* возникает при снижении секреции панкреатической липазы на 10% по сравнению с нормой. При выраженной стеаторее появляются поносы до 3-6 раз в сутки. Кал кашицеобразный, зловонный, с жирным блеском, реже водянистый.

При тяжелых формах ХП развиваются синдромы мальдигестии и мальабсорбции, что приводит к снижению массы тела, сухости и нарушению кожи, гиповитаминозам (в частности, недостатку витаминов А, Д, Е, К и других), обезвоживанию, электролитным нарушениям (снижению содержания в крови натрия, хлоридов, кальция), анемии; в кале обнаруживаются жир, крахмал, непереваренные мышечные волокна.

4.4.3 СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ИНКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ

Развивается вследствие снижения содержания инсулина в крови в связи с нарушением инкреторной функции поджелудочной железы.

Причины возникновения: разрушение поджелудочной железы опухолью, туберкулезным или сифилитическим процессом, острый и хронический панкреатит, атеросклероз, спазме сосудов (местная гипоксия островков Лангерганса),истощение после предварительного повышения функции (при излишнем употреблении в пищу усвояемых углеводов).

Клинически проявляется:

1. Нарушением толерантности к углеводам (у 75% больных).
2. Сахарным диабетом (слабостью, жаждой, повышением аппетита, снижением массы тела). Выявляется у 20-50% больных. Особенности течения панкреатического диабета: склонность к гипогликемиям, потребность в низких дозах инсулина, редкое развитие кетоацидоза, сосудистые осложнения.

4.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ – хроническое воспалительно-дистрофическое заболевание поджелудочной железы, вызывающее при прогрессировании патологического процесса нарушение проходимости ее протоков, склероз паренхимы и значительное нарушение экзо- и эндокринной функций.

Основные синдромы:

1. Воспалительно-деструктивный синдром
2. Синдром нарушения внешнесекреторной функции
3. Синдром нарушения инкреторной функции

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Основные синдромы:

1. Воспалительно-деструктивный синдром
2. Синдром нарушения внешнесекреторной функции
3. Синдром нарушения инкреторной функции
4. Синдром поражения других органов

ГЛАВА V

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

5.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

5.1.1 ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

- боли в животе
- диспепсические жалобы

БОЛИ В ЖИВОТЕ

Локализация. Боли чаще локализуются в правом подреберье, иногда - в подложечной области, вследствие растяжения, спазма или воспаления желчного пузыря (ЖП) и желчевыводящих путей.

Характер. При хроническом холецистите боли имеют тупой, ноющий, давящий, реже острый схваткообразный, сверлящий характер. Часть больных жалуется на ощущение тяжести в правом подреберье, чередование тупой и острой боли. Боль может быть постоянной (ежедневно) или эпизодической, длящейся несколько недель (не обязательно непрерывно) и сменяющейся полной ремиссией. При хроническом холецистите, протекающем с гипо- и атонией ЖП, боль в правом подреберье чаще всего умеренная , постоянная, тупая или ноющая. Интенсивная, приступообразная, острая боль, достигающая порой коликообразной силы (приступ желчной колики), характеризуется больным как “жесткая”, “невыносимая” боль и встречается обычно при калькулезном или шеечном холецистите, возникает в результате нарушения оттока желчи, вследствие спастического сокращения гладкой мускулатуры желчного пузыря и протоков. Может сопровождаться повторной

рвотой с примесью желчи, не приносящей, как правило, заметного облегчения, повышенным потоотделением, общей слабостью, чувством дурноты. После приступа желчной колики возможны познабливания, кратковременное повышение температуры тела, преходящая субиктеричность склер, а при закупорке камнем общего желчного протока или его ущемлении развивается механическая желтуха.

Иррадиация. Боль чаще иррадиирует кзади, вправо и вверх - в правую подлопаточную область, правую половину грудной клетки, правое плечо и надплечье.

Что провоцирует боль. Обильная еда; прием жирной, жареной пищи, яиц; острых приправ, а также газированных напитков, особенно холодных, алкоголя. Болевые ощущения могут появляться также при значительной физической нагрузке, подъеме тяжести, тряской езде, психоэмоциональном стрессе.

Чем купируются боли. Спастические боли облегчаются спазмолитиками, грелкой, теплой ванной. При гипотонии ЖП - приемом желчегонных препаратов (холекинетиков).

ДИСПЕПСИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ.

Связаны с нарушением оттока желчи в 12 перстную кишку. Наиболее частыми являются тошнота, рвота, понижение аппетита, ощущение горечи во рту, воздушная (пустая) или горькая на вкус отрыжка, метеоризм, урчание в животе, понос. Такой характер диспепсии носит название - билиарная диспепсия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Слабость, эмоциональная лабильность, бессонница, нарушение сна, раздражительность, снижение работоспособности обусловлены как соматическими, так и психогенными внешними воздействиями.

Повышение температуры тела связано, как правило, с развитием воспаления ЖП.

Кожный зуд - симптом, отражающий нарушение желчевыделения и раздражение нервных окончаний кожи желчными кислотами. Наиболее характерен для желчекаменной болезни, синдрома холестаза, но иногда может наблюдаться при некалькулезном холецистите в связи с застоем желчи.

У 25-50% больных в период обострения возможны боли некоронарного характера в области сердца, сердцебиение вследствие пузырно-кардиального рефлекса (см далее).

5.1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

При сборе анамнеза необходимо:

1. Выяснить факторы, которые могли играть роль в этиологии заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей:

- психоэмоциональные факторы
- нарушение режима питания (ритм, качество и количество употребляемой пищи)
- гиподинамия
- иннервационные нарушения различного генеза
- запоры
- беременность
- заболевания , приводящие к изменению химического состава желчи (ожирение, атеросклероз, сахарный диабет)
- инфекции, инвазии

2.Обратить внимание на следующие моменты:

- когда и как началось данное заболевание, когда возникли жалобы, при внезапном начале не было ли связи с бегом, прыжками
- находили ли когда - либо конкременты в желчном пузыре
- были ли когда-либо боли в правом подреберье, носящие коликообразный характер

Таким образом, при дискинезиях желчевыводящих путей имеют значение характер пищи, диетические погрешности (преобладание жирной, жареной пищи, а также исключение продуктов, обладающих естественным желчегонным эффектом), токсическое поражение гладкой мускулатуры и нервных ганглиев билиарной системы, перенесенный гепатит.

Для желчно-каменной болезни характерны: малоподвижный образ жизни, потребление высококалорийной пищи, богатой углеводами и жирами, нарушение обмена веществ (подагра, гликогеновая болезнь, галактоземия, фруктоземия, липоидозы, порфирии).

Для хронического холецистита имеет значение инфицирования желчного пузыря бактериальной флорой, нарушения оттока, наличие в анамнезе желчнокаменной болезни, инвазии простейшими (лямблиоз, амебиоз, фасциолез, описторхоз и др.).

5.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

5.2.2 ОБЩИЙ ОСМОТР

При осмотре больных хроническим некалькулезным холециститом существенных изменений может не наблюдаться. У некоторых больных при нарушении оттока желчи может появляться субиктеричность склер и слизистой оболочки мягкого неба, а при обтурации камнем общего желчного протока - желтушная окраска кожных покровов.

Расчесы на коже появляются при кожном зуде вследствие раздражения желчными кислотами нервных окончаний.

5.2.3 ОСМОТР ЖИВОТА

Пигментация в области правого подреберья появляется вследствие длительного применения больными для облегчения интенсивных болевых ощущений горячей грелки.

Отставание брюшной стенки в акте дыхания наблюдается при перихолецистите.

Выпячивание в правом подреберье можно увидеть при водянке ЖП.

5.2.4 ПАЛЬПАЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

В норме желчный пузырь не пальпируется. Если при пальпации удается прощупать желчный пузырь, это всегда свидетельствует о том или ином патологическом процессе. ЖП в виде округлого эластичного, умеренно напряженного и безболезненного образования (*симптом Курвазье-* Терье), выявляется при сдавлении дистального отрезка общего желчного протока злокачественной опухолью (головкой поджелудочной железы). Увеличенный, напряженный, болезненный ЖП (*симптом увеличенного болезненного желчного пузыря)* пальпируется при остром обтурационном холецистите. Редко можно пропальпировать ЖП при хроническом холецистите, в том числе калькулезном, это объясняется тем, что при хроническом холецистите утолщенная и фиброзноизменена стенка ЖП в большинстве случаев не способна к значительному растяжению, тем более при развитии спаечного процесса (перихолецистита) .

Пальпация выявляет локальную болезненность в зоне расположения желчного пузыря - пересечение наружного края правой прямой мышцы живота с правой реберной дугой (*симптом Кера)*. Этот симптом наблюдается в стадии обострения ХБХ, при развитии перихолецистита, при гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих путей, а также при растяжении ЖП при его гипотонии или атонии.

Для более точного выявления физикальных симптомов используется рабочая классификация Я.С. Циммермана (1992), в которой симптомы разделены на три группы.

Первая группа симптомов связана с сегментарными рефлексами билиарной системы (сегментарные рефлекторные симптомы) и обусловлены длительным раздражением сегментарных образований вегетативной нервной системы. Появляются ограниченные рефлекторные болевые зоны до 5 мм в диаметре.

Эти симптомы являются основными (патогномомичными) **симптомами обострения.** Различают: болевую рефлекторную зону *Маккензи* расположенную спереди в месте пересечения наружного края правой прямой мышцы живота с правой реберной дугой, что соответствует ветвлению в коже веточки IX грудного нерва. На задней поверхности грудной клетки по паравертебральной линии справа на уровне X - XI грудных позвонков локализуется рефлекторная болевая точка *Боаса*.

Симптом Алиева при надавливании на точки Маккензи и Боаса. появляется боль, иррадиирующая вглубь - по направлению к ЖП.

Вторая группа симптомов - рефлекторные болевые точки, расположенные в правой половине тела вне сегментов иннервации билиарной системы. Появляются при частых рецидивах заболевания, при упорном и длительном его течении. При этом вовлекаются в патологический процесс симпатический отдел ВНС, который в совокупности образует правосторонний реактивный (ирритативный) вегетативный синдром (ПРВС), характеризующийся появлением болевых ощущений при пальпации определенных точек и зон.

Среди болевых точек и зон, формирующих ПРВС, заслуживают внимания (рис.2): орбитальная точка *Бергмана*, затылочная *Ионаша*, точка *Мюсси-Георгиевского*, межлопаточная *Харитонова*, бедренная *Лапинского*, точка подколенной ямки, которые отражают тяжесть течения хронического холецистита.

Для выявления болезненности в указанных точках достаточно оказать давление на них кончиком указательного пальца. При определении болезненности в точке Мюсси (правосторонний френикус-симптом), расположенной в правой надключичной области между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, нужно оказывать легкие давление справа и слева, чтобы больной мог сравнить свои ощущения.

Третья группа симптомов - ирритативные симптомы, которые определяются при посредственном или опосредованном (путем сотрясения) раздражении воспаленного, а потому чувствительного ЖП.

Наиболее диагностически значимым является симптом *Мерфи*. Определяется он в положении больного на левом боку, сидя или стоя. Врач располагается справа или позади больного и во время выхода осторожно погружает кончики полусогнутых четырех пальцев правой руки под правую реберную дугу в области расположения ЖП. Симптом положителен, если во время глубокого вдоха больной внезапно прерывает дыхания из-за появления боли.

Симптом *Захарина-Кера*- боль при глубокой пальпации в правом подреберье в зоне локализации ЖП.

Симптом *Гаусмана*- боль ощущуется при коротком ударе ребром ладони ниже правой реберной дуги на высоте вдоха.

Симптом *Василенко-Лепене* - боль возникает при нанесении отрывистых ударов кончиками пальцев на вдохе ниже правой реберной дуги в зоне расположеня ЖП.

Симптом *Ортнера-Грекова*- боль появляется при сотрясении воспаленного ЖП в момент удара ребром ладони по краю правой реберной дуги.

Симптом *Айзенберга* - в положении стоя больной поднимается на носки, а затем быстро опускается на пятки: появляется в правом подреберье в результате сотрясения воспаленного ЖП.

Симптомы этой группы положительны **как в фазу обострения, так и ремиссии.**

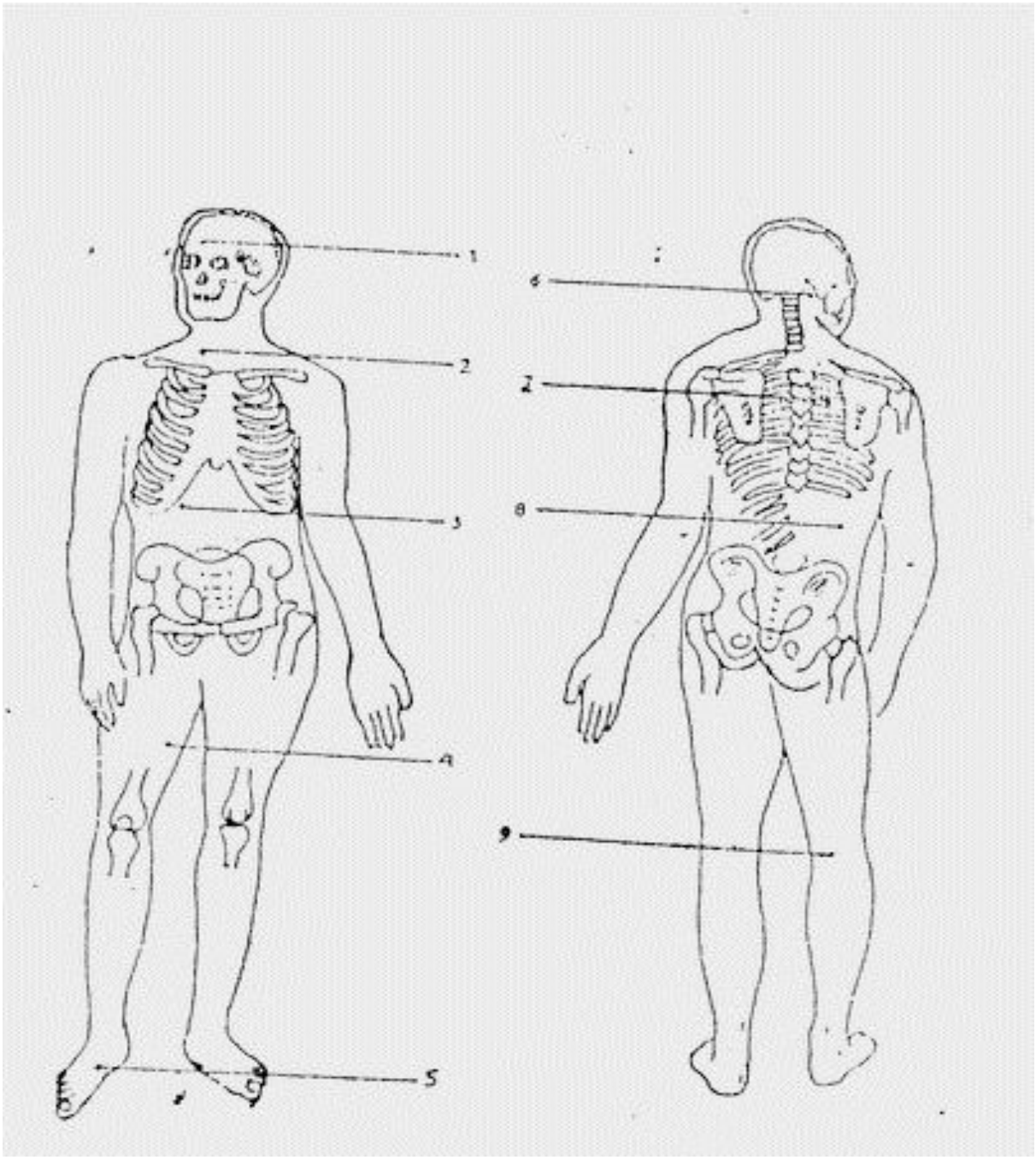


Рис. 2 Болевые точки выделяемые у больных с хроническим холециститом

1 - точка Бергмана, 2 - точка Мюсси, 3 - точка Макензи,

4 - точка Лапинского, 5 - платерная точка, 6 - точка Ионыша,

7 - точка Харитонова, 8 - точка Боаса, 9 - точка подколенной ямки

5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5.3.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дуоденальное зондирование

В основе метода лежит рефлекторная и гормональная стимуляция желчевыделения при введении в 12-перстную кишку холецистокинетических средств (раствор сернокислой магнезии 25%-50 мл, или растительное масло 30 мл, или раствор глюкозы 10-20%-40мл). При этом ЖП сокращается и синхронно расслабляется сфинктер Одди, что обеспечивает переход желчи из желчеводящих путей в двенадцатиперстную кишку. Дуоденальное зондирование проводят как с диагностической, так и с лечебной целью.

Выделяют три порции.

Порция А - содержимое двенадцатиперстной кишки. Объем ее 20-30 мл, имеет золотисто-желтую окраску. Обнаружение в содержимом порции А слизи, хлопьев в известной мере свидетельствует о воспалительном процессе в двенадцатиперстной кишке.

Порция В- пузырная желчь, объем ее в среднем составляет около 25-60 мл и зависит от объема желчного пузыря. В застойном ЖП содержится значительно больше желчи, при спастических дискинезиях объем пузыря уменьшается, а при атонических дискинезиях увеличивается. Отсутствие порции В заставляет предполагать закупорку пузырного протока камнем, сдавлением его опухолью. О воспалительном поражении ЖП судят по обнаружению в желчи В воспалительных элементов (хлопья, обилие лейкоцитов и слизи и др.).

Порция С - печеночная желчь, прозрачная золотисто-желтого цвета. Наличие воспалительных элементов в этой порции характеризует воспалительный процесс в желчных ходах. Отсутствие желчи порций С свидетельствует о нарушении проходимости желчных ходов, отсутствие порций В и С - о закупорке общего желчного протока.

Многофракционное дуоденальное зондирование (МФДЗ)

Проводится с целью изучения состава желчи и оценки состояния двигательной функции ЖП и тонуса сфинкторного аппарата (Одди, Люткенса, Мирицци).

Желчь собирается отдельными 5-минутными порциями. При фракционном дуоденальном зондировании можно выделить несколько фаз.

Клиническая оценка результатов *МФДЗ.*

Количество желчи, выделившейся в I фазу, дает представление о динамике ее базальной секреции (вне пищеварения) и частично - о функциональном состоянии сфинктера Одди. В норме выделяется 15-20 мл желчи в течение 10-15 мин.

После окончания выделения желчи в 12-перстную кишку через дуоденальный зонд медленно, в течение 5-7 минут вводят холецистокинетическое средство. В ответ на введение раздражителя сфинктер Одди рефлекторно закрывается и находится закрытым в течение всей второй фазы зондирования. II фаза- закрытого сфинктера Одди отражает время от введения холецистокинетического раствора до появления окрашенного желчью секрета. В это время желчь не выделяется. Эта фаза характеризует холестатическое давление в билиарном тракте, готовность желчного пузыря к опорожнению и его тонус. В норме фаза закрытого сфинктера Одди продолжается 3-6 минут. Увеличение времени закрытого сфинктера Одди больше 6 мин свидетельствует о повышении его тонуса и, возможно, о понижении холестатического давления в билиарном тракте.

III фаза -фаза пузырного протока (А желчи)- начинается с раскрытия сфинктера Одди и появления светлой желчи А до начала выделения темной концентрированной желчи желчного пузыря. В норме этот период продолжается 3-6 минут, в течение которого выделяется 3-5 светлой желчи из пузырного и общего желчного протоков. Данная фаза отражает состояние этих протоков. Увеличение времени III фазы более 7 минут указывает на повышение тонуса сфинктера Люткенса или на гипотонию ЖП.

Желчь I , II, III фаз составляет классическую порцию А обычного (нефракционного) дуоденального зондирования.

IVфаза - желчного пузыря (В желчи) - характеризует расслабление сфинктера Люткинса и опорожнение желчного пузыря. Выделение пузырной желчи вначале идет весьма интенсивно. В норме время опорожнения желчного пузыря составляет 20-30 минут, в течение этого времени выделяется в среднем 30-60 мл темно-оливковой пузырной желчи. Удлинение времени выделения пузырной желчи более 27-30 мин в сочетании с уменьшением количества выделяемой желчи за 5-минутные интервалы менее 8 мл/5 мин указывает на гипотонию ЖП. Напротив, укорочение времени сокращения ЖП менее 13-15 мин при одновременном увеличении объема выделяемой пузырной желчи за 5-минутные интервалы более 20мл/5мин говорит о гипертонической дискинезии ЖП.

V фаза - фаза печеночной желчи -С - наступает после окончания выделения В желчи. Эта фаза характеризует внешнесекреторную функцию печени. В V фазе значительное выделение печеночной желчи особенно в первые 5-10 мин более 7,5 мл/5мин, свидетельствует об активности сфинктера Мирицци, расположенного в дистальной части печеночного протока, назначение которого - воспрепятствовать ретроградному (восходящему) движению желчи при сокращении ЖП (в это время печеночная желчь накапливается в печеночном протоке выше сфинктера Мирицци). У больных хроническим холециститом активность сфинктера Мирицци регистрируется в 3,5 раза реже, чем у здоровых людей.

5.3.2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Используется для выявления камней ЖП, а также для оценки его двигательных функций. Этим методом диагностируют аномалии развития ЖП и протоков, приводящие к нарушению пассажа желчи в кишечник.

- *Ультразвуковое исследование желчного пузыря (УЗИ*)

УЗИ является в настоящее время ведущим методом диагностики заболеваний желчевыделительной системы, являясь наиболее экономичным, легко выполнимым методом. В 80% дает информацию об анатомо-топографическом состоянии ЖП, в 45% - о состоянии желчных протоков.

- *Рентгенологические исследование желчного пузыря*

Рентгенологические методы исследования ЖП (обзорная рентгенография, пероральная холецистография, внутривенная холецистохолангиография) применяются преимущественно для диагностики камней в желчевыводящих путях и нарушений моторной функции ЖП. Роль в диагностике хронического некалькулезного холецистита невелика.

- *Трансдуоденальная эндоскопическая ретроградна х*олецистография (холангиопанкреатография) позволяет провести осмотр большого дуоденального (фатерова) сосочка.
- *Компьютерная томография* используется в основном при подозрении на рак ЖП, ожирении 3-4 степени, непереносимости контрастных йодсодержащих веществ, высокой гипербилирубинемии.

5.4 СИНДРОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. БОЛЕВОЙ
2. БИЛИАРНОЙ ДИСПЕПСИИ
3. ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА
4. ИНТОКСИКАЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
5. ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
   - синдром вегетативной дисфункции
   - синдром предменструального напряжения
   - холецисто-кардиальный синдром
   - невротический - неврозоподобный
   - аллергический синдром (при обострении)

5.4.1 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Болевой синдром при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих протоков может быть вызван:

1. Висцеральной болью, обусловленной растяжением ЖП, что сопровождается умеренным повышением внутрипузырного давления. Боль при этом тупая, ноющая, не имеет четкой локализации и иррадиации, при этом отсутствует симптом мышечной защиты (дефанса). Иррадиация боли достигается тогда, когда импульс висцеральной боли достаточно интенсивен. Эта боль встречается при хроническом некалькулезном холецистите, гипомоторной дискинезией желчного пузыря.
2. Коликообразной болью (висцеральная боль с иррадиацией). Мощным импульсом к появлению коликообразной боли служит внезапное судорожное сокращение (спазм) мускулатуры ЖП и протоков, сопровождающееся повышением внутриорганного давления и сосудистыми нарушениями (ишемией). Для нее характерна четкая иррадиация, при этом имеется положительный симптом Менделя и локальное мышечное напряжение в месте проекции ЖП. Данная боль наблюдается при гипермоторной дискинезии и желчекаменной болезни.
3. Висцеро-соматическая боль обусловлена ирритацией поверхностно расположенных тканей (кожа, подкожная клетчатка, париетальная брюшина) снабженных чувствительными спинномозговыми нервами. Именно с этой болью связано появление в кожных покровах участков повышенной чувствительности (гиперестезии) и местной болезненности (болевых точек и зон), выявляемой при пальпации и перкуссии, а также симптома локальной мышечной защиты. Для нее характерна строгая локализация в месте раздражения (область ЖП) . Висцеро-соматическая боль сопровождает перихолецистит, осложняющий течение часто рецидивирующего хронического холицистита.

5.4.2. СИНДРОМ БИЛИАРНОЙ ДИСПЕПСИИ

Возникает при нарушение оттока желчи в 12-перстную кишку приводит к нарушению переваривания химуса в тонком кишечнике.

Участие желчи в пищеварении: желчь эмульгирует жиры; растворяет продукты гидролиза жиров, чем способствует их всасыванию; повышает активность панкреатических кишечных ферментов, особенно липазы; стимулирует желчеобразование. желчевыделение; усиливает моторную и секреторную функцию тонкой кишки; нейтрализует соляную кислоту, инактивирует пепсин в 12 п.к; обладает бактериостатическим свойством; способствует всасыванию из кишечника жирорастворимых витаминов, холестерина, солей кальция.

При нарушении желчевыделения развивается стеаторея. При ослаблении бактерицидного действия появляются симптомы гнилостной и бродильной диспипсии.

Клинико-лабораторные признаки: тошнота, пустая отрыжка, металлический вкус и горечь во рту, плохой аппетит, непереносимость некоторых видов пищи (жиров, алкоголя, продуктов, содержащих уксус и т.д.), упорное вздутие живота, запоры.

Копрограмма: стеаторея, гнилостная, бродильная диспепсии. (см. синдромы при заболеваниях)

5.4.3 СИНДРОМ ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА

Возникает в связи с развитием желчной гипертензии нарушается отток желчи из ЖП и желчевыводящих путей.

Клинико-лабораторные проявления:

- желчная колика
- кожный зуд и следы расчесов на коже
- желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек.
- билирубинемия конъюгированная (повышение прямого билирубина)
- повышение в крови содержания желчных кислот, щелочной фосфатазы и холестерина

- повышение билирубина в моче
- отсутствие уробилина в моче
- уменьшение или отсутствие стеркобилина в кале

5.4.4 ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ

Возникает под воздействием микробных эндо и экзотоксинов, аутоинтоксикации.

Клинико- лабораторные признаки:

- повышение температуры тела
- в общем анализе крови повышение СОЭ, лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево
- визуально порция В мутная, с хлопьями и слизью, при бактериологическом исследовании желчи возбудитель обнаруживается у 50% больных.

5.4.5 СИНДРОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

5.4.5.1**.** *Синдром неврозоподобный*

Сущность: в основе психоэмоциональных нарушений лежат как соматические, так и психогенные внешние воздействия.

Клинические признаки:

Психоэмоциональный статус больных характеризуется определенной стадийностью, связанной с тяжестью и длительностью заболевания.

- в легких случаях преобладает реакция тревоги
- в более тяжелых - ипохондрия, депрессия, психотические нарушения.

Не случайно стало нарицательным выражение: “желчный характер”

5.4.5.2 *Синдром вегетативной дисфункции*

Сущность: при частых рецидивах и прогрессировании заболевания в патологический процесс могут вовлекаться надсегментарные вегетативные образования, избыточная реактивность которых реализуется преимущественно через симпатический отдел ВНС.

Клинические проявления:

- яркие эмоциональные (психо-вегетативные) реакции;
- развитие симпато-адреналовых кризов (головные боли, пульсация в голове, сердцебиение, онемение и дрожание конечностей, бледность и сухость кожи, повышение температуры тела) .

5.4.5.3 *Холецисто-кардиальный синдром (ХКС)*

Развивается у 25-60% больных с заболеваниями ЖП.

Сущность: рефлекторное и инфекционно-токсическое влияние из пораженного ЖП на сердце.

Клинические признаки:

- боли в области сердца тупого: ноющего характера (кардиалгия)
- кратковременные нарушения ритма
- преходящая атриовентрикулярная блокада I степени
- метаболические изменения на ЭКГ.

5.4.5.4 *Аллергический синдром*

Сущность: бактериальные и пищевые аллергены способны вызвать аллергические воспаления ЖП, что подтверждается обнаружением эозинофилов в желчи и гистологических срезах стенок ЖП при отсутствии бактериальной инфекции.

Протекает по типу:

- крапивницы
- отека Квинке
- поллиноза
- лекарственной и пищевой интолерантности
- бронхоспазма
- артралгии.

Заболевание при этом приобретает упорный, часто рецидивирующий характер.

5.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ХОЛЕЦИСТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫЙ (БЕСКАМЕННЫЙ) **-** хроническое полиэтиологическое воспалительное заболевание желчного пузыря, как правило, сочетающееся с моторно-тоническими нарушениями (дискинезиями) желчевыделительной системы и изменениями физико-химических свойств и биохимического состава желчи (дисхолией). Продолжительность болезни более 6 месяцев.

Основные синдромы:

- Болевой
- Билиарной диспепсии
- Интоксикационно-воспалительный
- Вовлечение других органов и систем:
  - вегетативной дисфункции
  - неврозоподобный
  - холецисто-кардиальный
  - аллергический

ХОЛЕЦИСТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ **-** хроническое полиэтиологическое воспалительное заболевание желчного пузыря, сопровождающееся образованием в ней камней.

Основные синдромы:

- Болевой
- Билиарной диспепсии
- Интоксикационно-воспалительный
- Подпеченочного холестаза
- Вовлечение других органов и систем:
  - вегетативной дисфункции;
  - неврозоподобный;
  - холецисто-кардиальный;
  - аллергический .

ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ **-** расстройство тонуса желчных протоков, проявляющееся нарушением оттока желчи из печени и желчного пузыря в 12 перстную кишку и сопровождающееся появлением болей в правом подреберье (гиперкинетическая и гипокинетическая дискинезии).

Основные синдромы:

- Болевой
- Билиарной диспепсии
- Подпеченочного холестаза (при гипертоническом типе)
- Вовлечение других органов и систем:
  - вегетативной дисфункции;
  - неврозоподобный;
  - холецисто-кардиальный;
  - аллергический .

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ **-** обменное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием камней в желчном пузыре (холецистолитиаз, хронический калькулезный холецистит), в общем желчном протоке (холедохолитиаз), в печеночных желчных протоках (внутрипеченочный холелитиаз).

Основные синдромы:

- Болевой
- Билиарной диспепсии
- Подпеченочного холестаза
  - Вовлечение других органов и систем: вегетативной дисфункции; неврозоподобный; холецисто-кардиальный; аллергический

ГЛАВА 6

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ.

6.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.

6.1.1 ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

- Боли в правом подреберье
- Желтуха
- Зуд кожи
- Увеличение живота в объеме

Боли в правом подреберье тупые или ноющие, постоянные, могут восприниматься как чувство тяжести или полноты в правом подреберье - вызваны растяжением глиссоновой капсулы вследствие увеличения печени, Боли иррадиируют в правое плечо, лопатку, межлопаточное пространство, вследствие перехода возбуждения с правого диафрагмального нерва, обеспечивающего чувствительную иннервацию оболочки печени на чувствительные нервы, иннервирующие плечо, шею, которые берут начало в одних и тех же сегментах спинного мозга.

Желтуха – окрашивание слизистых и кожи в желтый цвет вследствие накопления билирубина в крови. Развивается в результате нарушения функции гепатоцитов, способность которых улавливать из крови билирубин, связывать с глюкуроновой кислотой и выделять его в желчные пути снижается. Интенсивность желтухи зависит от уровня билирубина в сыворотке крови. Субиктеричность - слабое окрашивание слизистых и кожи в желтый цвет может быть обнаружена при уровне билирубина в сыворотке крови 34,2 мкмоль/л. Желтуха становится явной при уровне билирубина – 120 мкмоль/л и выше.

Кожный зуд - носит постоянный характер, связан с увеличением концентрации желчных кислот в сыворотке крови и обусловлен раздражением ими сосочков кожи.

Увеличение живота в объеме наблюдается при скоплении жидкости в брюшной полости (асците) вследствие усиления транссудации жидкости из сосудистого русла при повышении давления в портальной вене, а также вследствие снижения синтеза альбумина и связанного с этим уменьшением онкотического давления крови при печеночно-клеточной недостаточности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

- Метеоризм
- Обесцвечивание кала
- Тошнота, рвота
- Потеря веса
- Апатия, сонливость
- Появление геморрагий
- Кровавая рвота, кровоточащий геморрой
- Боли в левом подреберье

Метеоризм - развивается вследствие застоя крови и отека слизистой оболочки ЖКТ при повышении давления в портальной вене и вследствие нарушения кишечного пищеварения и всасывания при нарушении отделения или состава желчи.

Обесцвечивание (посветление) кала связано с уменьшением выделения билирубина в кишечник и стеркобилиногена с калом. Полное обесцвечивания стула (ахолия) наблюдается при подпеченочном холестазе.

Тошнота, рвота обусловлены нарушением желчеобразования, желчевыделения и процессов пищеварения в кишечнике.

Потеря веса вплоть до истощения связана с глубокими нарушениями обмена веществ в организме, дистрофическими изменениями, выраженными во всех органах и тканях.

Апатия, сонливость – возникают вследствие токсического воздействия необезвреженных продуктов кишечного распада белка и аммиака на кору головного мозга при нарушении обезвреживающей функции печени.

Образование геморрагий - происходит вследствие нарушения синтеза печенью факторов свертывания крови. Второй причиной может быть снижение тромбоцитов в результате активации функции селезенки.

Кровавая рвота, кровоточащий геморрой появляются при высокой портальной гипертензии, повышении давления в портокавальных анастомозах, истончении их стенок, повреждении варикозных узлов вен пищевода и геморроидальных вен.

Боли в левом подреберье наблюдаются при быстром и значительном увеличении селезенки вследствие растяжении ее капсулы.

ОБЩИЕ ЖАЛОБЫ**:** слабость, быстрая утомляемость, прогрессирующее снижение трудоспособности, повышение температуры

Слабость, быстрая утомляемость, прогрессирующее снижение трудоспособности развиваются как общая реакция организма на гиповитаминоз, снижение белковой и обезвреживающей функций печени.

Повышение температуры чаще до субфебрильных цифр может наблюдаться при нарушении инактивации печенью белковых веществ пирогенной природы (пептидов и липополисахаридов клеточной стенки грамотрицательных бактерий), поступающих по воротной вене из кишечника.

6.1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Острое начало заболевания характерно для вирусного гепатита (А, В, С), а также наблюдается при острых токсических поражениях печени (при приеме больших доз алкоголя и его суррогатов, некоторых медикаментов,

гепатотропных ядов). Хронический вирусный гепатит развивается, как правило, после острого. Следует учитывать, что хронический гепатит часто развивается после безжелтушных вариантов острого гепатита (вирусной и токсической этиологии). Заболевание протекает с периодическими обострениями и ремиссиями. Причинами обострений могут являться употребление алкоголя, медикаментов, погрешности в диете (злоупотребление, жирной, жареной пищей), физические нагрузки, нервно-психические стрессы.

Для цирроза печени также характерно длительное течение. Поскольку цирроз печени является, как правило, исходом хронического гепатита (вирусной, алкогольной или токсической этиологии) поэтому в анамнезе у больных циррозом печени можно проследить период, соответствующий клинической картине хронического гепатита.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ

При сборе анамнеза жизни у больного с заболеванием печени необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Ранее перенесенный острый гепатит В, С, Д.
2. Указание на обнаружение в сыворотке крови маркеров гепатита.
3. Контакт с больным острым вирусным гепатитом.
4. Злоупотребление алкоголем.
5. Воздействие ядов: химических (соединений фосфора, мышьяка, ртути), лекарственных (барбитуратов, наркотических анальгетиков, больших доз диуретических средств, противотуберкулезных препаратов, антибактериальных препаратов: тетрациклин, левомицетин, гентамицин, эритромицин, олеандомицин и др.; непрямых антикоагулянтов, пропранолола, НПВС: индометацина, бутадиона, блокаторов H_2 – рецепторов гистамина: циметидина, ранитидина; парацетамола, метотрексата, фторотана), растительных (грибные яды)
6. Отношение пациента к группам риска:

- перенесенные операции, аборты, гемотрансфузии

- лечение у стоматолога
- оперативные вмешательства
- медицинские работники-хирурги, стоматологи, работники станций переливания крови и лабораторной службы
- нанесение татуировок на кожу
- беспорядочные сексуальные контакты

7. Семейный анамнез: доброкачественные гипербилирубинемии, гемолитическая анемия.
8. Сопутствующие заболевания: например, метастатическое поражение печени при раке ободочной и прямой кишки, молочной железы, желудка. Глистные инвазии: эхинококкоз, описторхоз.
9. Профессиональный анамнез: воздействие бензола и его гомологов (нитробензол, толуол, органические краски), некоторых металлов и металлоидов (свинец, ртуть, золото, марганец, мышьяк, фосфор)

6.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

6.2.1 ОБЩИЙ ОСМОТР

При общем осмотре больного с заболеванием печени необходимо оценить состояние больного:

Состояние удовлетворительное – может наблюдаться у больных с заболеванием печени в фазе ремиссии и без признаков портальной гипертензии и интоксикации.

Состояние средней тяжести - характерно для заболеваний печени, протекающих с признаками малой печеночно-клеточной недостаточности без энцефалопатии и комы, при асците, поддающемся лечению.

Состояние тяжелое - у больных с выраженной функциональной недостаточностью печени с нарушением сознания в виде резкой эйфории или его угнетения, вплоть до полной потери, при плохо поддающемся лечению асците, при резком истощении и развитии печеночной комы.

Сознание

Ясное при отсутствии признаков печеночно-клеточной энцефалопатии. Пациент ориентирован во времени, месте и окружающей обстановке, адекватно и без затруднений отвечает на вопросы.

Сознание расстроено:

Ступор – состояние оглушения: пациент заторможен, недостаточно ориентирован в месте, времени и окружающей обстановке, на вопросы отвечает с запаздыванием или невпопад.

Сопор (спячка) – состояние, при котором больного громким окриком или тормошением удается вывести из сна, но на вопросы он отвечает неосмысленно. Рефлексы сохранены.

Кома - бессознательное состояние, характеризующееся полным отсутствием реакции на внешние раздражители, отсутствием рефлексов и расстройством жизненно-важных функций.

Положение больного.

Активное - в период компенсации печеночно-клеточной недостаточности.

Вынужденное на боку – при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода.

Пассивное - при печеночной коме.

Вес

Похудание, мышечая гипотрофия, истощение вплоть до кахексии (крайняя степень истощения) отмечается вследствие нарушения белкового, жирового и углеводного обменов при циррозах, опухолях печени.

Осмотр кожи и слизистых

Кожные покровы при заболеваниях печени, как правило, имеют *желтушный цвет.* Желтуха может быть различной интенсивности. Желтушность кожи и видимых слизистых становится заметной при уровне сывороточного билирубина 50 ммоль/л и выше. Раньше всего окрашиваются в

желтый цвет склеры глаз, слизистые оболочки, нижняя поверхность живота, мягкое небо, затем окрашиваются ладони, подошвы и вся кожа.

Все желтухи подразделяются на истинные и ложные. Желтуха может быть различных оттенков. Оранжево-желтый цвет вызван накоплением в кожных покровах билирубина и обычно наблюдается в ранние сроки заболевания. При печеночно-клеточной желтухе кожа имеет типичный шафраново-желтый с красноватым оттенком цвет. Зеленовато-желтый цвет кожи обнаруживается при механической желтухе и сочетается с кожным зудом (см. подпеченочный холестаз), что обусловлено накоплением в крови биливердина.

Кроме заболеваний печени желтуха может иметь место при гемолитической анемии. При этом она имеет типичную лимонно-желтую окраску.

Ложная желтуха бывает при употреблении большого количества моркови, некоторых красителей и медикаментов вследствие накопления в коже каротинов. При осмотре можно обнаружить: желтушное окрашивание кожи, но не слизистых оболочек. Лабораторные признаки поражения печени отсутствуют.

Бледность наблюдается при кровотечениях из расширенных вен пищевода, кишечника, геморроидальных вен (при циррозе печени) и усиленном разрушении эритроцитов вследствие активации функции селезенки.

Расчесы на коже появляются при зуде вследствие раздражения желчными кислотами нервных окончаний в коже. Они наиболее выражены при холестазе подпеченочном, однако встречается и при внутрипеченочном холестазе вследствие нарушения синтеза желчных кислот поврежденными клетками печени.

Петехиальная сыпь и кровоизлияния в кожу (геморрагии) могут образовываться при проявлениях геморрагического диатеза, вследствие

уменьшения факторов свертывания крови и усиленного разрушения эритроцитов при гиперспленизме.

Крапивница, коревидная сыпь возникают при нарушении антитоксической функции печени.

Ксантоматоз – появление на веках, кистях рук, локтях, коленях, стопах, ягодицах, в подмышечных областях ксантолазм (внутрикожных желтых бляшек) связаных с повышенным содержанием в крови липидов при нарушении холестеринового обмена.

Лейконихии – появление белых участков на ногтевых пластинках, пальцы в виде «барабанных палочек» при циррозе печени

При нарушении дезинтоксикационной функции печени может наблюдаться гиперэстрогенемия, являющаяся причиной появления следующих симптомов:

Сосудистые звездочки – так называемые пульсирующие тнлнангиоэктазии от 0,5 до 1 см в диаметре, от которых во все стороны распространяются мелкие сосудистые веточки (эстрогены снижают тонус сосудов кожи). Располагаются на плечах, шее, лице, кистях, спине, слизистых носа, рта.

Печеночные ладони - симметричное покраснение ладоней и подошв в области тенара и гипотенара.

Сосудистые звездочки и печеночные ладони при надавливании бледнеют, а по прекращении давления вновь быстро краснеют.

Ярко-красная окраска языка

Гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин), изменение оволосения по женскому типу у мужчин- выпадение волос на груди, подбородке и животе.

Уменьшается рост волос в подмышечных областях и на лобке у женщин, нарушение менструального цикла, бесплодие.

6.2.2 ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА

Может обнаруживаться ангулярный стоматит (воспаление слизистой в углах рта) при нарушении обмена витаминов.

6.2.3 ОСМОТР ЖИВОТА

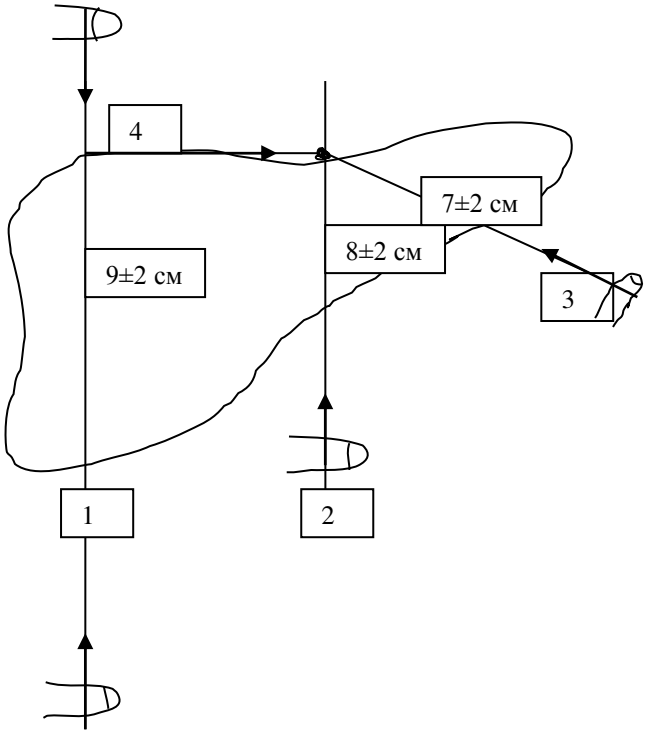
Расширение венозной сети обусловлено образованием анастомозов между системами воротной, верхней и нижней полыми венами (признак портальной гипертензии при циррозе печени). Голова медузы (caput Medusae) образована расширенными, набухшими и извитыми венозными коллатералями, располагающимися вокруг пупка и направляющимися от него лучеобразно (один из признаков выраженной портальной гипертензии). Это указывает на усиленный кровоток через облитерированную в норме пупочную вену.

Увеличенный отвислый живот в вертикальном положении и распластанный («лягушачий») живот в горизонтальном положении свидетельствует о наличии асцита, развившегося вследствие декомпенсированной портальной гипертензии (см. синдром портальной гипертензии). Этот симптом часто сочетается с выпячиванием пупка в связи с высоким внутрибрюшным давлением. Асимметрия живота: выбухание в правом подреберье может быть вызвано значительным увеличением печени, что характерно для опухолей, больших кист, гельминтозов печени (эхинококкоза, трематодозов: описторхоза, фасциолеза и др.); выбухание в левом подреберье - увеличением селезенки (спленомегалией), что наблюдается при портальной гипертензии.

2.2.4 ПАЛЬПАЦИЯ И ПЕРКУССИЯ ПЕЧЕНИ.

При исследовании печени вначале проводится перкуссия, а затем пальпация. При **перкуссии** печени определяют размеры и форму печени. В клинической практике размеры печени определяют по линиям предложенным М.Г. Курловым (рис. 3).

1. по средне-ключичной линии справа
2. по срединной линии
3. по линии соответствующей левой реберной дуге



1. По средне-ключичной линии справа - 9 ± 2 см;
2. По срединной линии - 8 ± 2 см;
3. По линии соответствующей левой реберной дуге - 7 ± 2 см.

Рис. 3. Размеры печени по Курлову

Таблица 8

Причины смещения границ печени

Верхней границы		*Нижней границы*	
Вверх	*вниз*	*вверх*	*вниз*

эхинококк, рак, абсцесс печени, сифилитическая гумма печени, сморщивание правого легкого, паралич диафрагмы, повышение внутрибрюшного давления, правосторонний экссудативный плеврит, поддиафрагмальный абсцесс	низкое стояние диафрагмы опущение печени, эмфизема, пневмо-торакс	уменьшение размеров печени (цирроз), повышение внутрибрюшного давления	опущение печени, увеличение печени (венозный застой, гепатит, цирроз).

Пальпация печени

Цель – охарактеризовать передне - нижний край печени, оценить:

- контуры,
- форму,
- болезненность,
- плотность (консистенцию).

Нижний край нормальной печени прощупывается по средне - ключичной линии справа на вдохе. При увеличении печени нижний край удается пальпировать по всем линиям.

Болезненность в правом подреберье характерна для:

1. Воспалительного процесса в ткани печени (при гепатитах) и в желчных ходах (при холангитах) с переходом воспаления на ее капсулу.
2. Сердечной недостаточности вследствие растяжения капсулы печени.
3. Опухолей печени.

2.2.4 ПАЛЬПАЦИЯ И ПЕРКУССИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Перкуссия селезенки

Цель: определить ориентировочную границу селезенки.

Используют тишайшую перкуссию.

Положение больного стоя или лежа на правом боку. Поперечник находится между 9 и 11 ребрами и составляет 4 - 6 см. Длинник перкутируют по 10 ребру. Он составляет 6-8см

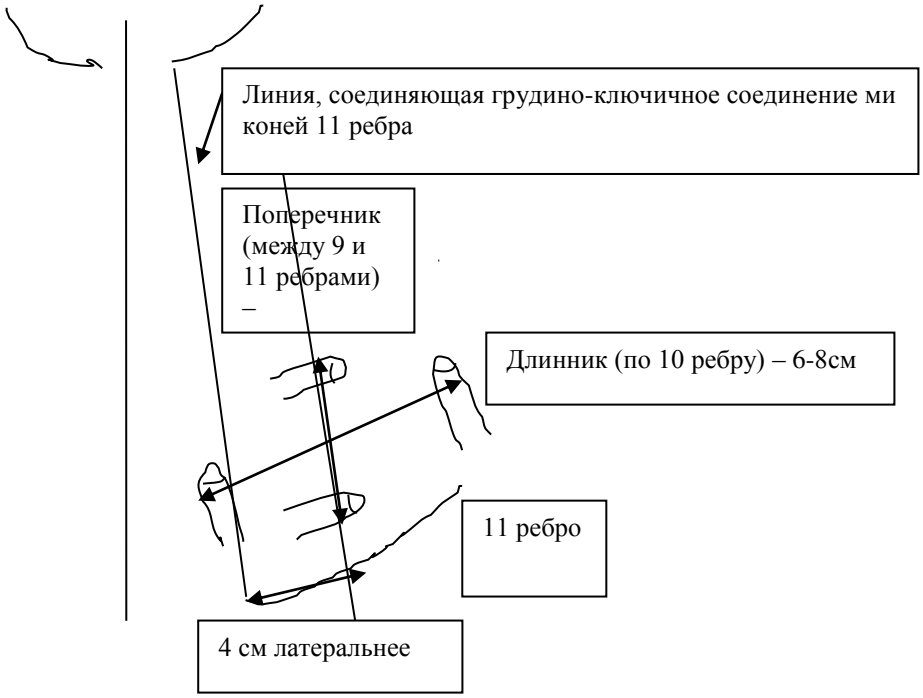


Рис 4. Перкуссия селезенки

Пальпация селезенки.

В норме селезенка пальпации недоступна. При увеличении или опущении селезенки в правом подреберье ее удается пальпировать. При пальпации оценивают: размеры, болезненность плотность (консистенцию), форму подвижность селезенки, наличие вырезок на переднем крае.

6.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

6.3.1 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ позволяет определить размеры печени и селезенки, акустическую неоднородность

печеночной паренхимы и признаки портальной гипертензии (нормальное давлениев портальной вене 120-150 мм вод. ст). Под контролем УЗИ можно проводить биопсию печени.

6.3.2. ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ проводится с целью дальнейшего гистологического исследования биоптата и определения стадии патологического процесса в печени. Прицельная биопсия рекомендуется при очаговых поражениях, «слепым» способом пользуются при диффузных поражениях. Диагностируемые заболевания: первичные и метастатические опухоли, цирроз печени(обнаружение ложных долек) хронические гепатиты (обнаружение «ступенчатых» или «мостовидных» некрозов паренхимы, лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрации долек) , гепатозы.

6.3.3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Компьютерная томография

Применяется с целью получения информации о плотности, гомогенности печеночной ткани, может показать небольшое количество асцитической жидкости.

Ангиографические исследования

- **Целиакография**

Метод исследования артериальной системы крови, основанный на введении контрастного вещества в чревную артерию через катетер. Это исследование позволяет выявить очаговые поражения печени (опухоли, кисты, абсцессы)

- **Спленопортография**

Контрастирование селезеночной и воротной вены с ее внутрипеченочными разветвлениями с последующей серийной рентгенографией. Метод позволяет получить изображение вен, а по их сечению и рисунку судить о наличии внепеченочных и внутрипеченочных причин портальной гипертензии, степени развития коллатерального кровообращения, характера распространенности и выраженности патологического процесса в печени.

Радиоизотопные методы (радиоизотопная гепатография и сканирование)

основаны на возможности с помощью радиометрической аппаратуры регистрировать и изучать распределение и перемещение введенных в организм радиоактивных веществ.

- **Радиоизотопная гепатография** позволяет оценить одновременно кровообразование в печени и поглотительно-выделительную функцию печени. У здоровых людей время полуочищения крови от краски (бенгальского розового) и время половинного поглощения краски печенью составляет 10-15 минут. Время максимального накопления краски в печени составляет16-22 минуты, а время максимального выделения половинного количества краски из печени в желчный пузырь и тонкую кишку колеблется между 75 и 110 минутами. При заболеваниях печени скорость, степень поглощения и выделения бенгальского розового уменьшаются.
- **Сканирование** с радиоактивным коллоидным золотом позволяет определить общую активность всей ретикулоэндотелиальной системы и функцию мезенхимы печени и селезенки. На цветной сканограмме визуально легко дифференцируется окрашенные различными цветами зоны, отражающие степень накопления изотопа в органах. У здоровых лиц наблюдается преимущественное накопление ^{198}Au в печени по сравнению с селезенкой. При циррозе печени поглощение ^{198}Au в увеличенной селезенке возрастает.

6.4. СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.

I. ГЕПАТОМЕГАЛИЯ
II. ЖЕЛТУХА (ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНАЯ)
III. ХОЛЕСТАЗ (ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ)
IV. ПЕЧЕНОЧНО – КЛЕТОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
    - Нарушение белковообразующей функции печени
    - Нарушение углеводной функции печени
    - Нарушение функции печени связанной с обменом липидов
    - Нарушение пигментной функции печени.

- Нарушение обезвреживающей функции печени

V. ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

- Асцит
- Варикозное расширение вен пищевода, кардиального отдела желудка, геморроидальных вен
- Спленомегалия
- Гиперспленизм (лабораторный).

VI. ЦИТОЛИЗ

VII. МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

СИНДРОМ ГЕПАТОМЕГАЛИЯ

Увеличение размеров печени. Может сопровождаться чувством тяжести в правом подреберье, вследствие растяжения капсулы печени.

При осмотре можно обнаружить выбухание в правом подреберье и в эпигастральной области.

При перкуссии определяются ординаты Курлова превышающие допустимые нормы (см. перкуссию печени).

При пальпации край печени можно прощупать по всем линиям от левого края печени до правого, удается прощупать и верхнепереднюю поверхность печени. Гепатомегалия является проявлением мезенхимально-воспалительного синдрома или внутрипеченочного холестаза.

ЖЕЛТУХА

Желтушное окрашивание кожи и слизистых вследствие повышенного накопления в тканях и крови билирубина. Субиктеричность - слабое окрашивание слизистых и кожи в желтый цвет может быть обнаружена при уровне билирубина в сыворотке крови 34,2 мкмоль/л. Желтуха становится явной при уровне билирубина – 120 мкмоль/л и выше.

В зависимости от причин гипербилирубинемии различают желтухи:

- *паренхиматозную (печеночную);*
- *механическую (подпеченочную, см. синдром подпеченочного холестаза);*
- *гемолитическую (надпеченочную),* при которой печень не в состоянии перевести свободный билирубин, образующийся в результате гемолиза эритроцитов в связанный билирубин (билирубинглюкуронид). (См. методические рекомендации: Семиотика и синдромология болезней крови).

Паренхиматозная желтуха (печеночно-клеточная)

Развивается при повреждении гепатоцитов, способность которых улавливать из крови билирубин, связывать его с глюкуроновой кислотой и выделять в желчные пути в виде билирубинглюкуронида снижается. В сыворотке крови повышается содержание как непрямого, так и прямого билирубина.

Причины паренхиматозной (печеночно-клеточной) желтухи: инфекционные: вирусный гепатит, лептоспироз; токсические: отравление грибами, соединениями фосфора, мышьяка, непереносимость лекарств.

При осмотре: раньше всего выявляется желтушное окрашивание на склерах глаз, нижней поверхности живота и мягком небе, затем окрашиваются ладони, подошвы. Цвет кожи может меняться от шафраново-желтого до красноватого; обесцвечивание кала (но не ахолия), темная окраска мочи (цвета пива).

При пальпации: болезненность в правом подреберье, печень плотная (при гепатите) или очень плотная (при циррозе).

При перкуссии: гепатомегалия, иногда может быть спленомегалия (при циррозе).

Лабораторные признаки: билирубинурия (появление билирубинглюкуронида в моче), уменьшение стеркобилина в кале, билирубинемия более 20 ммоль/л (превышение в 4 - 10 раз): повышение непрямого билирубина (за счет недостаточной функции гепатоцитов), повышение прямого билирубина (за счет обратного заброса билирубинглюкуронида из желчных в кровеносные капилляры).

Паренхиматозная желтуха (энзимопатическая)

Развивается при врожденной недостаточности ферментов, ответственных за коньюгацию билирубина. Причины энзимопатических желтух: синдром Жильбера, Ротора, Дабина-Джонсона.

Клинические признаки: жалобы на периодическое пожелтение склер.

При сборе анамнеза: желтуха новорожденных при рождении. Возникновению проявлений предшествует нервное переутомление и сильное физическое напряжение.

При осмотре: перемежающаяся иктеричность склер (реже желтуха), в некоторых случаях частичное желтушное окрашивание ладоней, подошв, подмышечных областей, носогубного треугольника.

Лабораторные признаки: билирубинемия (непрямая фракция при синдроме Жильбера) и прямая фракция при синдроме Дабина – Джонсона и синдроме Ротора, незначительное повышение уробилина в моче, нормальное содержание стеркобилина в кале, белковые осадочные пробы и содержание протромбина в норме.

СИНДРОМ ХОЛЕСТАЗА

Развивается вследствие нарушения секреции и оттока желчи. Это может быть связано:

- с повреждением собственно желчесекретирующих механизмов гепатоцита, либо с нарушением резорбции воды и других преобразований желчи в мельчайших желчных ходах (первичные нарушения, **внутрипеченочный холестаз**)
- с развитием желчной гипертензии, связанной с препятствием нормальному току желчи в желчевыводящих путях (вторичные нарушения, внепеченочный, **подпеченочный холестаз**).

Внутрипеченочный холестаз.

Внутрипеченочный холестаз характеризуется уменьшением тока желчи и ее поступления в двенадцатиперстную кишку при отсутствии механического

повреждения и обструкции внепеченочного билиарного тракта. Это может быть обусловлено или нарушением механизмов образования и транспорта желчи на уровне гепатоцитов в результате гепатоцеллюлярной патологии, или является следствием повреждения внутрипеченочных протоков, или их сочетанием.

Клинические проявления холестаза обусловлены тремя факторами:

1. Избыточное поступление элементов желчи в кровь: кожный зуд (раздражение сосочков кожи желчными кислотами), не снимающийся симптоматическими препаратами, часто предшествующий желтухе, желтуха, ксантелазмы, темная моча,а также системные проявления (острая почечная недостаточность, развитие острых эрозий и язв в желудке).
2. Уменьшение количества или отсутствие желчи в кишечнике: понижение аппетита, тошноту, рвоту, вздутие и урчание в животе, диарея (стеаторея), посветление кала.
3. Воздействие компонентов желчи на печеночные клетки: симптомы печеночно-клеточной недостаточности.

Жалобы на ощущение давления, распирания в области правого подреберья, (вследствие расстройства секреции желчи).

При осмотре желтуха имеет яркий, красноватый, рубиновый оттенок, ксантелазмы (отложение холестерина в коже век).

При пальпации: гепатомегалия незначительная, печень умеренно-плотная с гладким краем (при гепатите), бугристая (при циррозе) или не пальпируется. Спленомегалия не бывает большой и не сочетается с гиперспленизмом.

Лабораторные признаки: гипербилирубинемия за счет повышения прямого (коньюгированного) билирубина. Появление желчных кислот в сыворотке крови и в моче. Повышение холестерина сыворотки крови (норма 3,9-6,2мм/л) ,липопротеидов низкой плотности, щелочной фосфатазы сыворотки крови (норма 2-5 ед. - это неспецифический фермент, продуцируемый в желчных ходах), ГГТП. Появление желчных пигментов в моче (билирубин мочи), снижение стеркобилина в кале (см таблицу 8).

Отличительной особенностью внутрипеченочного от внепеченочного холестаза является повышение ферментов цитолиза: АСАТ, АЛАТ и ГГТП.

Таблица 9

Лабораторная диагностика желтух

Показатель	Норма	Типы желтух			
		Надпеченочная	Печеночная		Подпеченочная
			С холестазом	Без холестаза	
Общий билирубин (ммоль/л)	15 -20	↑ до 2-3 N	50-250		100-500
Прямой билирубин (% к общему)	25	N	↑ до 50 и более	↑	↑ до 50 и более
Непрямой билирубин (% к общему)	75	↑	↓	↑	↑
АлАТ, АсАТ (МЕ/л)	Менее 40	N	N или ↑	↑	↑ или N
ЩФ (МЕ/л)	Менее 295	N	↑	N	↑ более 3 N
ГГТП (ЕД)	15 – 40	N	↑		> до 5 и более N
Билирубинурия	-	-	+	- +	+
Уробилин в моче	-	↑	-	- +	-
Стеркобилин в кале	N	↑	↓	↓	↓

СИНДРОМ ПЕЧЕНОЧНО - КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность: нарушение функций печени вследствие повреждения гепатоцитов.

Причины возникновения: гепатиты, гепатозы, циррозы, опухоли печени, гельминтозы печени, в том числе эхинококкоз, отравление гепатотропными ядами и лекарствами, септические состояния, обширные травмы, ожоги.

Клинические проявления зависят от степени выраженности синдрома печеночно-клеточной недостаточности. При хроническом гепатите характерна умеренная степень печеночно-клеточной недостаточности, выявляемая преимущественно лабораторно. Степень нарушения белкового отека недостаточна для развития гипопротеинемических отеков и геморрагий. Напротив для цирроза печени характерно формирование отеков и геморрагического синдрома.

Основные индикаторы печеночно-клеточной недостаточности:

1. Нарушение белково-образующей функции печени
2. Нарушение углеводной функции печени
3. Нарушение липидной функции печени
4. Нарушение пигментной функции печени
5. Нарушение обезвреживающей функции печени

Таблица 10

Нарушение белково-образующей функции печени

Сущность	Клинические признаки	Лабораторные признаки
нарушение синтеза белка	• понижение веса, • появление отеков и водянки полостей (см. асцит)	гипоальбуминемия < 60%, гипопротеинемия < 60 г/л
нарушение синтеза факторов свертывания крови	• подкожные геморрагии на локтевых сгибах, голенях, местах, подвергающихся давлению, • кровоточивость десен, • кровотечения носовые, маточные	снижение основных факторов свертывания крови: • протромбинового индекса < 80%, • фибриногена < 4,0 мкмоль/л • проакцелерина < 85%, • проконвертина < 80%
Нарушение синтеза транспортных белков	• анемии	• снижение в крови трансферрина, ферритина.

Таблица 11

Нарушение углеводной функции печени

Сущность	Клинические признаки	Лабораторные признаки
• нарушение синтеза и распада гликогена, • инактивации инсулина, • угнетение окислительных процессов в печени.	не характерны, однако при тяжелом поражении печени могут наблюдаться признаки гипогликемии: • выраженная слабость, • чувство голода, • тремор рук, • головокружение.	Гипогликемия < 3,3 ммоль/л (при тяжелых поражениях печени).

Таблица 12

Нарушение липидной функции печени.

Сущность	Клинические признаки	Лабораторные признаки
снижение синтеза сложных липидов, в том числе холестерина.	не характерны	гипохолестеринемия < 3,9 ммоль/л

Таблица 13

Нарушение пигментной функции печени (см. синдром желтухи)

Сущность	Признаки	
	клинические	лабораторные
Нарушение коньюгации непрямого билирубина с глюкуроновой кислотой, транспорта его через клеточную мембрану гепатоцита и	Желтуха: • желтое окрашивание кожи, слизистых оболочек и склер • посветление кала; • темная окраска мочи (цвета пива).	• билирубинурия, • уробилинурия, • уменьшение стеркобилина в кале, • билирубинемия > 20 ммоль/л (повышение уровня билирубина в крови как непрямого, так и прямого). • бромсульфалеиновая проба -

обратного заброса в кровь коньюгированного билирубина.		повышенная задержка краски в крови через 45 минут > 5% (нарушение экскреторной функции печени)

Таблица 14

Нарушение обезвреживающей функции печени.

Сущность	Признаки	
	клинические	лабораторные
пораженные гепатоциты теряют пособность задерживать и обезвреживать с помощью ферментов токсичные малорастворимые в воде или связанные с белками вещества	• сосудистые звездочки (см. осмотр) • печеночные ладони • малиновый язык, имеющий гладкую поверхность • гинекомастия у мужчин • уменьшение роста волос в подмышечных областях и на лобке у женщин • печеночный запах, • нарушение психики • двигательные расстройства (данные симптомы являются признаками энцефалопатии и печеночной комы).	• снижение клиренса антипирина <36,8мл/мин, • снижение клиренса кофеина <60 мл/мин, • снижение выделения гиппуровой кислоты < 3-3,5г,

Примечание: Кровь воротной вены, поступающая от желудочно-кишечного тракта, содержит различные токсические вещества (мочевину, аммиак, мочевую кислоту, кетоны, фенолы, индол и др.), для которых печень служит барьером. В печени в результате

окислительно-восстановительных процессов токсичные вещества преобразуются в менее токсичные растворимые вещества и выводятся с мочой и желчью. Поражение паренхимы печени уменьшает ее обезвреживающие возможности. Токсические вещества попадают в большой круг кровообращения в обход печени.

При печеночно-клеточной недостаточности нарушение обезвреживающей функции печени может привести к развитию печеночной энцефалопатии и печеночной комы.

Печеночная энцефалопатия и печеночная кома

Сущность: при выраженной печеночно-клеточной недостаточности воздействие токсических веществ на кору головного мозга (вследствие значительного снижения обезвреживающей функции печени) приводит к угнетению процессов биологического окисления в мозге, уменьшению продукции энергии в мозговой ткани, падению мембранного потенциала клеток и торможению передачи возбуждения в синапсах.

Прогрессирование печеночно-клеточной недостаточности, ведущее к развитию печеночной энцефалопатии и печеночной комы, как правило, возникает при: нерациональном лечении диуретиками, эвакуации асцитической жидкости, воздействии интеркуррентной инфекции, токсических веществ и алкоголя.

Клинические признаки **печеночной энцефалопатии**.

1. Нарушение психики: нарушение сна в виде инверсии, появление кошмарных сновидений, постепенно снижается память, интеллект, развивается деменция.
2. Двигательные расстройства: мелкий тремор пальцев рук напоминает «взмахи крыльев птицы», брадикинезия, повышение сухожильных рефлексов, нарушение координации.
3. Изменение энцефалограммы (ЭЭГ): непостоянные и слабовыраженные.

Печеночная энцефалопатия при отсутствии своевременного рационального лечения переходит в печеночную кому.

Основные клинические признаки печеночной комы.

1. Развивающаяся кома: сонливость, выраженная дезориентация в пространстве, хлопающий тремор пальцев рук, век, атаксия, дизартрия, рефлексы повышены, расстройство почерка, лихорадка, возможны диспепсические нарушения; ЭЭГ- нарастание амплитуды, замедление ритма.

3. Сопор, выраженная дезориентация в пространстве. Нечеткая речь; ЭЭГ: снижение амплитуды при редком ритме.

4. Печеночная кома (глубокая кома): печеночный запах из рта, на фоне желтухи петехиальная сыпь и кровоизлияния под кожу (см. нарушение белково-образующей функции печени и синдром гиперспленизма), сознание отсутствует, исчезает реакция на болевые раздражители, появляется ригидность мышц конечностей и затылка, маскообразное лицо, клонус мышц стопы, хватательные и хоботковые рефлексы, наблюдается поражение сфинктеров, остановка дыхания. На электроэнцефалограмме – снижение амплитуды и ритмов вплоть до полного отсутствия (изолиния).

Лабораторные признаки печеночной энцефалопатии и печеночной комы: лейкоцитоз более $10{,}2\times10^9$/л, гиперазотемия более 14,8 ммоль/л, гипоальбуминемия менее 54г/л, гиперглобулинемия более 40%, снижение содержания в крови холестерина менее 3,9 г/л, протромбинового индекса менее 80%, проакцелерина менее 85%, проконвертина менее 80%, тромбоцитов менее 180×10^8/л с изменением их функциональных свойств, калия в сыворотке крови менее 3,4 ммоль/л и эритроцитах менее 78 ммоль/л, снижение холинестеразы и специфических печеночных ферментов, билирубинферментная диссоциация, т.е. нарастание уровня общего билирубина и снижение ранее повышенной активности аминотрансфераз.

СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (ПГ)

Сущность: ПГ- повышение давления в бассейне воротной вены, вызванное нарушением кровотока различного происхождения и локализации- в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене.

Существует три группы причин портальной гипертензии:

- Пресинусоидальная: внепеченочная- тромбоз портальной и селезеночной вен, печеночная- саркоидоз, шистосомоз
- Синусоидальная (печеночная): цирроз печени, врожденный печеночный фиброз
- Постсинусоидальная: веноокклюзионная болезнь

При диффузных заболеваниях печени развивается **внутрипеченочная портальная гипертензия**, связанная с нарушением ангиоархитектоники печени и формированием ложных долек. В синусоидальной сети ложных долек нарушены механизмы, регулирующие ток крови по ветвям воротной вены, печеночной артерии и печеночных вен. По имеющимся анастомозам соединяются ветви воротной вены и печеночной артерии непосредственно с ветвями печеночных вен, т.е. развиваются прямые портопеченочные шунты. Коллатеральное кровоснабжение также идет по внепеченочным портокавальным анастомозам. В результате сдавления и деформации узлами регенерирующей паренхимы разветвлений печеночных вен возрастает сопротивление кровотоку и повышается давление в системе воротной вены.

Клинические признаки:

1. Метеоризм и диспепсические явления в виде неустойчивого стула, снижения аппетита, тошноты.
2. Спленомегалия, гиперспленизм.
3. Расширение вен переднебоковой стенки живота, появление симптома «головы медузы».
4. Формирование портокавальных анастомозов: развитие варикозно-расширенных вен нижей трети пищевода, кардиального отдела желудка, геморроидального сплетения, вследствие повышения давления в портальной вене, приводящего к расширению и истончению стенки портокавальных анастомозов. Рентгенологически и эндоскопически выявляется варикозное расширение вен пищевода, желудка, вен геморроидального сплетения.

5.Появление жидкости (транссудата) в брюшной полости – асцит.

6.Кровотечение из варикознорасширенных вен пищевода, желудка, геморроидального сплетения.

Асцит.

Основной причиной асцита является повышение гемодинамического давления в системе воротной вены. В тот момент, когда оно превосходит онкотическое давление, начинается пропотевание плазмы через сосудистую стенку. На фоне гипоальбуминемии эти процессы развиваются быстро. Повышение секреции альдостерона и снижение его инактивации в гепатоцитах способствует задержке натрия и повышению осмолярности тканей.

Клинические признаки:

- При осмотре выявляется выпячивание пупка, пупочная и паховая грыжи.
- При перкуссии определяется тупой звук над боковыми областями живота, а посредине живота – кишечный тимпанит (больной находится в горизонтальном положении). Перемещение больного на левый бок вызывает смещение тупого звука влево, а в области правого фланга выявляется тимпанический звук. При небольшом количестве жидкости перкутируют больного в положении стоя. При асците появляется тупой или притупленный звук в нижних отделах живота, исчезающий при переходе больного в горизонтальное положение. При напряженном асците выявляется симптом баллотирования: врач кончиками пальцев наносит отрывочные толчки по поверхности живота, а ладонь его левой руки, наложенная на противоположную стенку живота, ощущает волну.

Лабораторные признаки: гипоальбуминемия (снижение альбуминов менее 56%), гипернатриемия (более 157 ммоль/л), гипокалиемия (менее 3,8ммоль/л), асцитическая жидкость светло-желтая, стерильна, плотность менее 1015, белка содержит мало (5-20г/л), цитоз незначительный (менее 250 клеток в 1 мм^2).

Варикозное расширение вен пищевода желудка и геморроидальных вен.

Сущность: вследствие повышения гемодинамического давления в системе портальной вены формируются портокавальные анастомозы. В условиях портальной гипертензии быстро происходит истончение стенок и развитие варикозно-расширенных вен, что создает условия для нарушения их целостности, и развития кровотечения. На фоне печеночно-клеточной недостаточности со снижением гемокоагуляции они приобретают угрожающий, а подчас несовместимый с жизнью характер.

Клинические признаки.

- Жалобы и анамнез: прослеживается прогрессирующая дисфагия, вследствие варикознорасширенных вен нижней трети пищевода. Наблюдается появление наружного и внутреннего геморроя, склонного к кровоточивости. Часто усиливаются проявления кишечной диспепсии.
- При осмотре: бледность кожных покровов, которая указывает на повторные кровотечения; расширение вен на передней поверхности брюшной стенки, формирование симптома «головы медузы».
- При аускультации: наличие симптома Крювелье-Баумгартена – длительный сосудистый шум в области пупка, возникающий при прохождении крови через варикозно-измененные вены анастомозов.
- При развитии **кровотечения** из варикозно-расширенных вен пищевода, кардиального отдела желудка наблюдаются обильная кровавая рвота и мелена.
- Вследствие кровотечения могут развиться симптомы острой постгеморрагической анемии: сухость во рту, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, холодный пот, снижение АД.

Лабораторные признаки, характерные для кровотечения из варикозно-расширенных вен: анемия (Hb< 120г/л), ретикулоцитоз (>5%), тромбоцитоз (>320).

Выявить варикозно-расширенные вены можно с помощью эндоскопических и рентгеноконтрастных исследований желудочно-кишечного тракта.

Спленомегалия (увеличение размеров селезенки)

Причины спленомегалии: портальная гипертензия, системная гиперплазия ретикулогистиоцитарной ткани селезенки, отложение гемосидерина, увеличение числа атриовенозных шунтов.

Клинические признаки:

- Чувство тяжести в левом подреберье.
- При осмотре: выпячивание в области левого подреберья.
- При пальпации: селезенку удается пальпировать.

Лабораторные признаки не характерны.

Гиперспленизм

Сущность: повышение функции селезенки вследствие депонирования и усиленного разрушения эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов в застойной селезенке и иммунных механизмов, приводящих к торможению костно-мозгового кроветворения и иммунной цитопении. Развитие данного синдрома является прогностически неблагоприятным признаком.

Гиперспленизм – преимущественно лабораторный синдром, так как складывается из признаков анемии, лейкопении и тромбоцитопении.

Развивается при наружных и внутренних кровотечениях. Выявляются признаки геморрагического синдрома: жалобы на слабость, головокружение, шум в ушах, головная боль.

Клинические признаки:

- При осмотре: бледность кожных покровов, петехии на коже.
- При пальпации: селезенка может не пальпироваться.
- При перкуссии: размеры селезенки могут не меняться.

Лабораторные признаки: анемия менее 100г/л, тромбоцитопения менее 100×10^9/л, лейкопения менее $3,5\times10^9$/л.

СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА

Комплекс лабораторных симптомов, свидетельствующих об активности патологического процесса в печени, связанного с разрушением гепатоцитов.

Причины возникновения: разрушение гепатоцита и нарушение проницаемости его клеточных мембран; при этом оболочка гепатоцита становится проницаемой для внутриклеточных ферментов.

Лабораторные признаки: увеличение уровня аланинаминотрансферразы (АЛАТ норма – 0,1-0,68 мкмоль/л), аспартатаминотрансферразы (АСАТ норма – 0,1-0,45 мкмоль/л). Степень подъема активности трансаминаз (АСАТ, АЛАТ) свидетельствует о выраженности цитолиза.

Примечание: помимо основных показателей цитолиза также могут наблюдаться увеличение активности гаммаглютамилтрансферразы (ГГТФ) , глютаматдегидрогеназы (ГЛДГ), сорбитдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы ($ЛДГ_5$).

СИНДРОМ МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

Синдром мезенхимально-воспалительный это комплекс клинико-лабораторных симптомов, обусловленных активацией ретикулогистиоцитарной (мезенхимальной) системы печени. Поступающие в печень антигены взаимодействуют с мезенхимальной системой, в результате возникают различные нарушения гуморального и клеточного иммунитета, которые в свою очередь поддерживают воспаление.

Клинические признаки: повышение температуры до субфебрильных цифр, может наблюдаться гепатомегалия, спленомегалия.

Лабораторные признаки: лейкоцитоз > 9×10^9 /л, увеличение СОЭ > 15мм/ч, положительные белковоосадочные пробы: тимоловая (>4ед.), сулемовая (< 1,9 ед.), повышение α_2-(> 7–8%) и γ-глобулинов (> 12,8-19,0%), появление СРБ, повышение иммуноглобулинов - индикаторов нарушения иммунных процессов. Они являются антителами. Обнаружение эмбриоспецифических глобулинов (фетопротеинов) в сыворотке крови (в норме в сыворотке крови взрослого человека отсутствуют), обнаружение неспецифических антител (в норме

отсутствуют) к тканевым и клеточным антигенам (антител к нативной и денатурированной ДНК, синтетической РНК и гладкомышечных антител).

Мезенхимально-воспалительный синдром встречается при остром вирусном и хроническом активном гепатитах, при активном и первичном билиарном циррозах печени, хронических алкогольных заболеваниях печени.

СИНДРОМ МАЛЫХ ПРИЗНАКОВ

Комплекс признаков, характерных для развития злокачественных опухолей печени.

Клинические признаки: недомогание, повышенная утомляемость, уменьшение массы тела, потливость, лихорадка (опухолевая интоксикация).

Лабораторные признаки:

1. Повышение α-фетопротеина сыворотки выше 20 нг/мл.
2. Увеличение содержания щелочной фосфатазы (проявление холестаза),
3. Увеличение сывороточных трансаминаз (проявление синдрома цитолиза).
4. Повышение уровня α_2 и γ-глобулинов.

2.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ **-** полиэтиологический хронический диффузный процесс в печени без перестройки ее структуры, продолжающийся более 6 месяцев и эволюционирующий или не эволюционирующий в цирроз печени.

Основные синдромы:

1. Гепатомегалия
2. Желтуха
3. Внутрипеченочный холестаз.
4. Печеночно-клеточной недостаточности (нарушение белковообразующей функции печени – геморрагический синдром, нарушение пигментной функции печени – паренхиматозная желтуха).
4. Цитолиз.

5. Мезенхимально-воспалительный.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ **-** прогрессирующее или, реже непрогрессирующее диффузное хроническое полиэтиологическое заболевание печени, которое является конечной стадией развития неблагоприятно протекающих форм хронического гепатита, следствием затруднения оттока желчи или крови из печени или генетически обусловленных метаболических дефектов и характеризуется значительным уменьшением массы функционирующих клеток печени, резко выраженной фиброзирующей реакцией, перестройкой структуры паренхимы и сосудистой сети печени.

Основные синдромы:

1.Синдром портальной гипертензии.

- Асцит
- Расширение вен переднебоковой стенки живота
- Варикозное расширение вен пищевода, желудка, геморроидальных

2. Спленомегалия
3. Гиперспленизм (клиническое проявление – геморрагический синдром)
4. Цитолиз
5. Мезенхимально-воспалительный
6. Печеночно-клеточной недостаточности (нарушение белково-образующей функции печени - геморрагический, нарушение пигментной функции печени – паренхиматозная желтуха, нарушение обезвреживающей функции печени - Печеночная энцефалопатия и печеночная кома)
7. Билиарная диспепсия
8. Внутрипеченочный холестаз

КОНТРОЛЬНО - ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается пищеводная рвота от желудочной (ст.8)
2. Какие особенности общего осмотра можно выявить у больных с заболеваниями пищевода? (ст.10)
3. Объясните особенность диспептических жалоб больных с язвенной болезнью 12 п.к. (ст 15)
4. Назовите отличительные особенности клинических проявлений язвы в зависимости от локализации.(ст15)
5. Какие синдромы развиваются вследствие нарушения эвакуации из желудка (ст. 27)
6. Что включает в себя понятие "кишечная диспепсия"? (ст. 44)
7. Какие синдромы развиваются вследствие нарушения всасывания в тонком кишечнике? (ст.48)
8. Назвать копрологические синдромы кишечной диспепсии? (ст.49-50)
9. Назовите особенности анамнеза больных с патологией ПЖ (ст.63)
10. Какие симптомы входят с синдром воспалительно-деструктивный (ст. 67)
11. Какие болевые симптомы появляются при частых рецидивах заболеваний желчного пузыря, при упорном и длительном его течении (ст. 85)
12. Синдром печеночно-клеточной недостаточности. Расскажите, в чем сущность, основные индикаторы ПКН (ст. 112)
13. Синдром портальной гипертензии. Дайте определение, перечислите клинические признаки. (ст. 115)
14. Печеночная энцефалопатия и печеночная кома. Назовите сущность синдромов, основные клинические признаки.(ст. 114)
15. Синдром цитолиза. Назовите сущность синдрома и лабораторные признаки. (ст. 119)

16. Какие инструментальные исследования применяются при заболеваниях печени. Какую информацию несут эти методы? (ст. 102)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов

1.ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ДИСФАГИИ, ВСЛЕДСТВИЕ СУЖЕНИЯ ПИЩЕВОДА, ХАРАКТЕРНЫ
1) нарушение глотания твердой пищи
2) нарушение глотания жидкой пищей
3) наблюдается эпизодически
4) наблюдается постоянно
5) сопровождается регургитацией
6) отсутствует регургитация

2. ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФАГИИ ПИЩЕВОДА ХАРАКТЕРНЫ
1) нарушение глотания твердой пищи
2) нарушение глотания жидкой пищей
3) наблюдается эпизодически
4) наблюдается постоянно
5) сопровождается регургитацией
6) отсутствует регургитация

3. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СИНДРОМА ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТОПРОДУКЦИИ (ГИПЕРАЦИДНОСТИ) ОТНОСИТСЯ
1) кислая отрыжка, запоры
2) тухлая отрыжка, поносы
3) горький вкус во рту, метеоризм

4.СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА, ОТРЫЖКА ТУХЛЫМ, ТОШНОТА, РАСПИРАЮЩИЕ БОЛИ В ЭПИГАСТРИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
1) гастрита с секреторной недостаточностью
2) гиперацидного гастрита
3) язвенной болезни двенадцатиперсной кишки

5. ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНО ОБЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИВОТА, ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК НАД ЖИВОТОМ ГРОМКИЙ, ТИМПАНИЧЕСКИЙ. ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ
1) ожирению

2) асциту
3) метеоризму

6. СИМПТОМ МЕНДЕЛЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
1) воспаления (раздражение) брюшины
2) перивисцерита желудка при язвенной болезни желудка
3) острого воспаления желчного пузыря

7. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПРИ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ С ВЫРАЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
1) язык обложен белым налетом
2) сухой язык (язык «как щетка»)
3) влажный розовый язык
4) «географический» язык
5) гладкий полированный язык с атрофией сосочков

8. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЯ
1) язык обложен белым налетом
2) сухой язык (язык «как щетка»)
3) влажный розовый язык
4) «географический» язык
5) гладкий полированный язык с атрофией сосочков

9.ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ПОХУДАНИЕ, СНИЖЕНИЕ КИСЛОТОПРОДУКЦИИ И АНЕМИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ В ПЛАНЕ:
1) пенетрации язвы
2) малигнизации язвы
3) перфорации язвы
4) кровотечения
5) стенозирования пилорического отдела желудка

10. О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ УРЧАНИЕ, ВЫЯВЛЯЕМОЕ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ СЛЕПОЙ КИШКИ
1) симптом выявляется в норме
2) в брюшной полости имеется свободная жидкость
3) имеется стеноз привратника
4) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у больного с колитом)

5) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым энтеритом)

11. ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ ВОКРУГ ПУПКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОРАЖЕНИИ
1) тонкого кишечника
2) прямой кишки
3) сигмовидной кишки
4) поперечно ободочной кишки

12. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДАННЫЕ АУСКУЛЬТАЦИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
1) нормальная перистальтика кишечника
2) резко усиленная (бурная) перистальтика кишечника
3) ослабление перистальтики кишечника
4) отсутствие перистальтики кишечника («гробовая тишина»)
5) усиленная перистальтика в мезогастрии

13. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ПЕРИТОНИТА ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЙ ЯЗЫКА
1) язык обложен белым налетом
2) сухой язык (язык «как щетка»)
3) влажный розовый язык
4) «географический» язык
5) гладкий полированный язык с атрофией сосочков

14. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ВОЛНЫ (ФЛЮКТУАЦИИ) ПРИ БИМАНУАЛЬНОЙ ПЕРКУТОРНОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
1) симптом выявляется в норме
2) в брюшной полости имеется свободная жидкость
3) имеется стеноз привратника
4) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у больного с колитом)
5) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым энтеритом

15. ШУМ ПЛЕСКА В ЭПИГАСТРИИ ВЫЯВЛЯЕМЫЙ ЧЕРЕЗ 5-6 ЧАСОВ ПОСЛЕ ЕДЫ ХАРАКТЕРЕН
1) симптом выявляется в норме
2) в брюшной полости имеется свободная жидкость
3) имеется стеноз привратника

4) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у больного с колитом)
5) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым энтеритом)

16. ПРИ СТЕНОЗЕ ПРИВРАТНИКА ПРИ ОСМОТРЕ И ПЕРКУССИИ ЖИВОТА, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1) на глаз заметна усиленная бурная перистальтика кишечника. Живот вздут.
2) живот увеличен в размерах, куполообразно вздут, участвует в дыхании. Пупок втянут. Перкуторно – громкий тимпанит.
3) живот увеличен; в горизонтальном положении – распластан, в вертикальном - выгладит отвисшим. Пупок выбухает. На боковых поверхностях живота расширенная венозная сеть.
4) в эпигастрии хорошо заметно выбухание и периодически возникающие волны антиперистальтики

17. ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНО ОБЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИВОТА, ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК НАД ЖИВОТОМ ГРОМКИЙ, ТИМПАНИЧЕСКИЙ. ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ
1) ожирению
2) асциту
3) метеоризму

18. ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ТАКОЕ «МЕЛЕНА»
1) жирный блестящий, плохо смывающийся кал
2) жидкий кал черного цвета
3) обесцвеченный кал (серый)
4) черный оформленный кал

19. КАК ИЗМЕНЯТСЯ ДАННЫЕ АУСКУЛЬТАЦИИ ЖИВОТА ПРИ ЭНТЕРИТЕ
1) нормальная перистальтика кишечника
2) резко усиленная (бурная) перистальтика кишечника
3) ослабление перистальтики кишечника
4) отсутствие перистальтики кишечника
5) сосудистые шумы

20. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ИНКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ
1) нарушением толерантности к углеводам
2) сахарным диабетом

3) панкреатитом

21. В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ БОЛЕЗНЕННОСТЬ В ЗОНЕ ШОФФАРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
1) поражении тела желудка
2) поражении пилорической части желудка
3) поражении 12-перстной кишки
4) поражении 12-перстной кишки и/или пилорической части желудка
5) поражении пилорической части желудка, 12-перстной кишки и/или головки pancreas

22. ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ДИСПЕПСИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) тошнотой
2) рвотой приносящей облегчение
3) рвотой не приносящей облегчение
4) метеоризмом

23. ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
1) спленомегалия
2) снижение функции внешней секреции (гипоферментемия)
3) желтуха
4) повышение активности аминотрансфераз
5) гепатометомегалия

24. ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ
1) болевого синдрома
2) синдромом подпеченочной желтухи
3) симптомов интоксикации и повышения неспецифических острофазовых показателей
4) повышением холестерина крови
5) гиперамилазурией, повышением диастазы (амилазы) крови и мочи.
6) энтеральным синдромом

25. РЕЗКАЯ БОЛЕЗНЕННОСТЬ В ЭПИГАСТРИИ ПРИ ПОКОЛАЧИВАНИИ ВЫПРЯМЛЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ ПРАВОЙ РУКИ (ПОД УГЛОМ 90˚ К БРЮШНОЙ СТЕНКЕ) - ЭТО СИМПТОМ:
1) Ортнера

2) Менделя
3) Мюсси
4) Керра

26. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИМПТОМА КУРВУАЗЬЕ
1) увеличенный, безболезненный, эластичный и подвижный желчный пузырь у больного с механической желтухой
2) увеличенный, безболезненный, эластичный желчный пузырь, желтухи нет
3) механическая желтуха, желчный пузырь не увеличен, пальпация его болезненна
4) паренхиматозная желтуха, желчный пузырь не увеличен, пальпация его болезненна

27. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ МЕРФИ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) панкреатите
2) гастрите
3) холецистите
4) гепатите

28. ГИПОКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) ноющими болями в правом подреберье
2) удлинением, расширением, замедленным опорожнением желчного пузыря выявляемых при рентгенологическом исследовании
3) частым сочетанием с язвенной болезнью желудка

29. ДЛЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКЕ ХАРАКТЕРНО
1) постоянные, непрерывно усиливающиеся боли в верхней половине живота с иррадиацией вниз и напряжением мышц брюшной стенки
2) острые приступообразные боли в правом подреберье с иррадиацией вверх и вправо, возможно напряжение мышц брюшной стенки
3) тупые длительные боли в правом подреберье с иррадиацией вверх и вправо, возможно напряжение мышц брюшной стенки

30. ЗАСТОЮ ЖЕЛЧИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ СПОСОБСТВУЕТ

1) беременность
2) малоподвижный образ жизни
3) частые приемы пищи
4) опущение внутренних органов

31. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОТЛИЧАЕТСЯ:
1) наличием цитолитического синдрома
2) наличием холестатического синдрома
3) наличием портокавальных и кава-кавальных анастомозов
4) наличием синдрома холемии
5) наличием паренхиматозной желтухи

32. ГЕПАТОМЕГАЛИЯ, СПЛЕНОМЕГАЛИЯ И МЕЛЕНА ВЫЗЫВАЮТ ПОДОЗРЕНИЕ НА:
1) кровоточащую язву 12-перстной кишки
2) кровоточащие вены пищевода при циррозе печени
3) тромбоз мезентериальной артерии
4) неспецифический язвенный колит
5) кровоточащие язвы желудка

33. К ИНДИКАТОРАМ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ ОТНОСИТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ:
1) АсАТ, АлАТ
2) ЛДГ, КФК
3) ЩФ, ГГТП

34. ПЕРВЫЙ РАЗМЕР ПЕЧЕНИ ПО КУРЛОВУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1) по срединной линии
2) по среднеключичной линии справа
3) по передне-подмышечной линии справа
4) по окологрудинной линии
5) по средне-ключичной линии слева.

35. БЛЕДНО-ЖЕЛТАЯ КОЖА, ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ НЕКОНЪЮГИРОВАННОГО БИЛИРУБИНА, ГИПЕРХОЛИЧНЫЙ КАЛ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:
1) механгической желтухи
2) гемолитической желтухи
3) паренхиматозной желтухи
4) энзимопатии

36. «СОСУДИСТЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ», ПАЛЬМАРНАЯ ЭРИТЕМА, СИМПТОМ «ГОЛОВЫ МЕДУЗЫ» ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО:
1) циррозом печени
2) хроническим гепатитом
3) язвенной болезнью

37. ДЛЯ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО:
1) повышение уровня только непрямого билирубина
2) повышение уровня только прямого билирубина
3) повышение обеих фракций билирубина

38. БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ВОСПАЛЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1) активность трансаминаз
2) уровень билирубина
3) тимоловая проба

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1:

Больной М., 33 года.

Жалобы на изжогу, тошноту, боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, иногда ночью и при длительном голодании, боли стихают после приема пищи и после рвоты, которая возникает на высоте болей. Отмечает повышенную утомляемость, раздражительность.

Из анамнеза: считает себя больным 2 месяца, когда появились вышеуказанные жалобы. Заболевание связано с нерегулярным питанием, с нервным перенапряжением.

Объективно: эмоционально лабилен, влажные ладони. При поверхностной пальпации болезненность в эпигастральной области несколько вправо от срединной линии.

Обследования: При проведении внутрижелудочной pH-метрии уровень pH в теле желудка равен 0,7

Задание

1. Выделите симптомы, сгруппируйте в синдромы, объясните их патогенез.
2. Сформулируйте предварительный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования и опишите ожидаемые результаты.
4. Охарактеризуйте основные принципы лечения.

ЗАДАЧА 2:

Больной Ш., 45 лет.

Жалобы на постоянные боли в эпигастральной области, тупого характера, усиливающиеся после приема жирной пищи; на вздутие, урчание в животе; стул 3-4 раза в день полуоформленный, обильный, светло-серого цвета, жирный с неприятным запахом; слабость, вялость, раздражительность.

Анамнез: болен 2 года, последние 6 месяцев поносы участились, начал худеть. Обострения связаны с нарушениями в диете и приемом алкоголя.

Объективно: пониженного питания, кожные покровы сухие, бледные, заеды в углах рта. Язык слегка обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. Положительный симптом Дежардена, болезненная пальпация в точках Мейо-Робсона I и II.

Обследования: Общий анализ крови: гемоглобин 98 г/л эритроциты 3 х 10^{12}/л, лейкоциты 10 х 10^{9}/л СОЭ 18 мм/час. Амилаза крови 270 МЕ/л.

Копрограмма: Кал полуоформленный, светло-серого цвета, жирный. Микроскопия: капли нейтрального жира, непереваренные мышечные волокна с поперечной исчерченностью, зерна крахмала внеклеточного.

УЗИ: фиброз поджелудочной железы.

Задание

1. Выделите симптомы, сгруппируйте в синдромы, объясните их патогенез.
2. Сформулируйте предварительный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования и опишите ожидаемые результаты.
4. Охарактеризуйте основные принципы лечения.

Задача 3

Больной П., 40 лет.

Жалобы на общую слабость, утомляемость, головную боль, снижение памяти, боли в правом подреберье, тошноту, рвоту, метеоризм, снижение аппетита, кровотечение из носа, пожелтение кожи.

Из анамнеза: Болен около двух лет - периодически боли в правом подреберье, слабость. Злоупотребляет алкоголем более 15 лет. В течение двух недель отмечает повышение температуры до 37,2°С, носовые кровотечения, пожелтел,

Объективно: состояние средней тяжести. Кожа и видимые слизистые желтушные. Резко пониженного питания, имеются признаки атрофии скелетной мускулатуры, снижение оволосения, пальмарная эритема, на коже туловища телеангиоэктазии в виде звездочек. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД – 120/80 мм. рт. ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Печень – 14-13-10 см. Плотная, край закругленный, ровный, болезненный. Селезенка не пальпируется, размеры 4*6 см.

Обследования: Общий анализ крови: эритроциты – 2,4 х 10^{12}/л, Нв – 94г/л, СОЭ – 28 мм/ч, лейкоциты – 3,6 х 10^{9}, тромбоциты – 180 х 10^{9}/л.

Биохимический анализ крови: общий белок 49 г/л, альбумины – 46%, глобулины – 54%: α_1 – 2%, α_2 – 19%, β -7% γ - 22%. Билирубин-65 мкмоль/л, прямой – 40 мкмоль/л, непрямой 25 мкмоль/л, АСАТ – 2,5 мкмоль/л, АЛАТ – 1,8 мкмоль/л, тимоловая проба – 10 ед., протромбиновый индекс – 60%, холестерин 2,1 ммоль/л.

Задание

1. Выделите симптомы, сгруппируйте в синдромы, объясните их патогенез.
2. Сформулируйте предварительный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования и опишите ожидаемые результаты.
4. Охарактеризуйте основные принципы лечения.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1-1),4),5)	**2-2),3),5)**	**3-1)**	**4-1)**	**5-3)**
5-2)	**7-5)**	**8-3)**	**9-20**	**10-1)**
11-1)	**12-3)**	**13-4)**	**14-2)**	**15-3)**
16-4)	**17-3)**	**18-2)**	**19-2)**	**20-2)**
21-5)	**22-1),2),4)**	**23-2),3),4)**	**24-1),2),3),4)**	**25-2)**
26-1)	**27-3)**	**28-1),2)**	**29-2)**	**30-1,)2),4)**
31-3)	**32-2)**	**33-1)**	**34-2)**	**35-2)**
36-1)	**37-3)**	**38-1),2)**		

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

ЗАДАЧИ № 1

Выделены следующие синдромы:

1. Болевой синдром. В него входят симптомы:

– Боли в эпигастрии, возникающие через 3-4 часа после еды, иногда ночью и при длительном голодании; боли стихают после приема пищи и после рвоты.

– Пальпаторно - болезненность в области эпигастрия несколько вправо от срединной линии.

Патогенез: данная локализация и суточный ритм болей указывают на вовлечение двенадцатиперстной кишки (ДПК) в патологический процесс. На основании условий задачи боли являются висцеральными и вероятнее всего связаны с непосредственным раздражением язвы активным желудочным соком (боли поздние, «голодные», ночные). Прием пищи облегчает боль, так как пища становится буфером желудочного сока и меньшее его количество контактирует с поверхностью язвы в ДПК. При рвоте боль стихает непосредственно за счет

эвакуации наружу избытка желудочного сока, в результате также меньшее его количество контактирует с поверхностью язвы.

2. Синдром желудочной диспепсии (по типу ацидизма).

– Изжога;
– Тошнота;
– Рвота на высоте болей.
– Уровень pH в теле желудка равен 0,7

Патогенез: изжога это раздражение слизистой пищевода кислым содержимым, возникает вследствие дисфункции кардиального жома. Рвота на высоте болей – защитный рефлекторный акт, направленный на эвакуацию наружу причинного фактора, вызвавшего боль, в данном случае – избытка желудочного сока. Тошнота – ощущение, часто предшествующее рвоте. Уровень pH в теле желудка равный 0,7 указывает на повышенную кислотообразующуюфункцию желудка.

3. Синдром астено-вегетативный.

– Раздражительность;
– Эмоциональная лабильность;
– Влажность ладоней;
– Повышенная потливость.

Патогенез: данные симптомы свидетельствуют о дисфункции вегетативной нервной системы, в частности, преобладания ее парасимпатического отдела. Это ведет к усилению желудочной секреции (прямое влияние n.Vagus на обкладочные клетки желудка), повышению тонуса и перистальтики желудка, желудочно-дуоденальному рефлюксу и забросу кислого содержимого в ДПК. Слизистая ДПК не способна длительно противостоять действию активного желудочного сока и возникает «самопереваривание» ее ослабленного участка.

4. Синдром клинико-анамнестический.

– Болен 2 месяца (говорит об остроте процесса);
– Связь заболевания с нерегулярным питанием, нервным перенапряжением.

Предварительный диагноз:

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, впервые выявленная.

План обследования, ожидаемые результаты:

1. ФГДС – является наиболее надежным методом диагностики язвенной болезни. Вероятнее всего в данном случае будет обнаружен язвенный дефект в ДПК. При обнаружении язвенного дефекта эндоскопически остальные методы имеют вспомогательное значение.

2. R-контрастное исследование. Вероятнее всего в данном случае будет обнаружен рентгенологический симптом «ниши» в ДПК. Выявление изъязвления этим методом составляет 70-80%. Его необходимо обязательно применять при наличии дополнительных симптомов, указывающих на нарушение эвакуации пищи, стеноз привратника, при подозрении на опухолевое поражение, дивертикулез, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

3. Исследование кислотообразующей функции желудка.

Желудочное зондирование: вероятнее всего в данном случае будет увеличен объем желудочного сока натощак, значительно увеличена кислотная продукция как в базальную, так и в стимулированную фазы секреции.

4. Диагностика хеликобактерной инфекции тем или иным методом (цитологический, уреазный, иммунохимический, биологический). При обнаружении H.pylori необходимо провести эрадикационную терапию.

5. Копрограмма. Позволяет диагностировать проявления синдрома кишечной диспепсии, выявить скрытое внутреннее кровотечение (реакция Грегерсена). Вероятнее всего в данном случае отклонений по копрограмме не будет; реакция Грегерсена может быть как положительной, так и отрицательной.

План лечения:

В процессе лечения язвенной болезни необходимо достичь следующих целей:

1. В острый период (при наличии открытой язвы):

– Диета (дробное питание с механическим, химическим, физическим щажением) – №1.

– Эрадикационная терапия (направлена на ликвидацию Нр). Используются различные схемы, наибольшая эффективность достигается комбинацией из 3-4 препаратов в течение 1-2 недель, например:

Амоксициллин + Метронидазол + Де-Нол + Омепразол.

– Обволакивающие, вяжущие препараты, например Де-Нол.

– Прокинетики, нормализующие работу сфинктеров: Метоклопрамид (Церукал).

– Препараты, улучшающие регенерацию слизистой, например: Витамины B_1, B_6, Метилурацил.

2. <u>В стадии стойкой ремиссии</u>: санаторно-курортное лечение на курортах с гастроэнтерологическим профилем (например санаторий Нижне-Ивкино).

3. <u>Профилактика обострений</u>:

- Противорецидивная терапия – проводится для профилактики обострений весной и осенью в течение 1-2 месяцев, например: омепразол 20 мг (по 1 таб. на ночь в течение всего октября и апреля);
- Исключение нервно-психического перенапряжения;
- Ограничение в диете жирных, жареных, острых блюд.

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ № 2

Выделены следующие синдромы:

<u>1. Воспалительно-деструктивный - ведущий синдром:</u>

а) болевой синдром:

- жалобы на боли в эпигастральной области, усиливающиеся после приема жирной пищи;
- положительный симптом Дежардена

- болезненная пальпация в треугольнике Шоффара, точках Мейо-Робсона I и II
- фиброз железы по данным УЗИ.

Патогенез: боли тупого характера возникают под воздействием на рецепторный аппарат поджелудочной железы ишемии участков паренхимы вследствие воспаления и фиброза.

Усиление болей после приема жирной пищи связано с растяжением протоков поджелудочной железы при повышении в них давления в результате увеличения выработки секрета. Болезненость, выявляемая в треугольнике Шоффара, точках Мейо-Робсона I и II, указывает на поражение всех отделов поджелудочной железы.

б) Панкреатическая гиперферментемия

- амилаза крови 64 г/л в час,

Патогенез: при нарушении нормального оттока ферменты секрета поджелудочной железы попадают в кровь.

2. Синдром нарушения внешней секреции:

- слабость,
- пониженного питания,
- кожные покровы сухие, бледные, заеды в углах рта,
- изменения кожи и её дериватов,
- вздутие, урчание в животе, стул 3-4 раза в день,
- копрологические признаки стеатореи (кал полуоформленный, светло-серого цвета, жирный, с неприятным запахом, капли нейтрального жира) и креатореи (непереваренные мышечные волокна с поперечной исчерченностью, зерна крахмала внеклеточного).

Патогенез: недостаточное поступление ферментов поджелудочной железы в полость кишечника приводит к нарушению переваривания и всасывания пищи, что проявляется симптомами кишечной диспепсии.

3. Синдром клинико-анамнестический.

- болен 2 года,
- последние 6 месяцев ухудшение,
- обострения связаны с нарушениями в диете и приемом алкоголя.

Как видно из анамнеза - заболевание хроническое, так как длится в течение 2-х лет, характеризуется рецидивами и ремиссиями, имеет прогрессирующее течение. В настоящее время имеет место обострение заболевания.

Предварительный диагноз: Хронический панкреатит с постоянным болевым синдромом, внешнесекреторной недостаточностью, рецидивирующее течение, в фазе обострения.

План обследования, ожидаемые результаты:

1. Для определения внешнесекреторной функции поджелудочной железы применяют исследование панкреатического сока, полученного методом дуоденального исследования 2-х канальным зондом до и после внутривенной стимуляции железы одновременно секретином и панкреозимином. Определяют объем сока, дебит бикарбонатов и некоторых ферментов. Предполагаемые результаты: снижение объема сока, нарушение секреции бикарбонатов в сторону снижения, уменьшение ферментов.
2. Для определения внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы можно использовать тест толерантности к глюкозе.
3. Радиоизотопные методы исследования: выявляется картина пятнистого неравномерного распределения изотопов из-за фиброза.
4. Обзорное рентгенологическое исследование брюшной полости: позволяет выявить очаги обызвествления в паренхиме железы.
5. Компьютерная томография: позволяет выявить очаги обызвествления в поджелудочной железе, исключить другую патологию.
6. Анализ мочи на амилазу: возможно повышение амилазы мочи.
7. Биохимический анализ крови: выявление гипопротеинемии, диспротеинемии, снижения железа, нарушений электролитного баланса, обусловленных нарушением процессов всасывания.

Принципы лечения:

1. Соблюдение диеты, не усиливающей секреторную функцию поджелудочной железы, а также отказ от алкоголя.

2. Коррекция экзокринной и эндокринной недостаточности поджелудочной железы (ферментные препараты, инсулин).

3. Купирование болевого синдрома и предупреждение осложнений (ингибиторы протонной помпы, Н2 гистаминоблокаторы, антациды, спазмолитики, М-холинолитики, антибиотики). Антиферментные препараты для подавления активности ферментов в крови.

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ № 3

Выделены следующие синдромы:

1. Синдром печеночно-клеточной недостаточности «большой» - ведущий.

В него входят симптомы:

- Нарушение белково-образующей функции: общую слабость, утомляемость, резко пониженного питания, имеются признаки атрофии скелетной мускулатуры, кровотечения из носа, геморрагии на коже, общий белок 49 г/л, альбумины – 46%, протромбиновый индекс – 60%.
- эритроциты - $2{,}4\times10^{12}$/л, Нв – 94 г/л. (синдром анемический)
- Нарушение пигментной функции: Синдром желтухи (паренхиматозной печеночно-клеточной). Пожелтение кожи и видимых слизистых, билирубин-65 мкмоль/л, прямой – 40 мкмоль/л, непрямой 25 мкмоль/л.
- Нарушение обезвреживающей функции: снижение оволосения, пальмарная эритема, телеангиоэктазии в виде звездочек на коже туловища, признаки печеночной энцефалопатии - головная боль, снижение памяти.
- Нарушение липидной функции: холестерин 2,1 ммоль/л.

Патогенез: Развивается вследствие некроза гепатоцитов, при этом нарушаются все функции печени. Кровотечение из носа, снижение протромбинового

индекса - наблюдаются в результате уменьшения в крови факторов свертывания при снижении белково-образующей функции печени.

Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов (цветовой показатель 0,8) свидетельствует о гипохромной анемии вследствие рецидивирующих носовых кровотечений, а также нарушения синтеза белков, входящих в состав гемоглобина и участвующих в транспорте железа. Снижение уровня холестерина свидетельствует о нарушении синтеза гепатоцитами сложных липидов. Кожа и видимые слизистые желтые, кожный зуд, повышение общего билирубина за счет как прямого, так и непрямого – признаки печеночно-клеточной желтухи вследствие нарушения целостности гепатоцитов, способность которых улавливать из крови билирубин, связывать его с глюкуроновой кислотой и выделять в желчные пути в виде билирубинглюкуронида снижается. Происходит выход билирубина в синусоиды, а затем и в капилярное русло.

2. Синдром цитолиза.

- АСАТ – 2,5 мкмоль/л,
- АЛАТ – 1,8 мкмоль/л.

Патогенез: увеличение концентрации ферментов цитолиза указывает на повреждение клеточных мембран гепатоцитов и повышение их проницаемости.

3. Синдром мезенхимально-воспалительный.

- Температура субфебрильная 37,2°С,
- Тимоловая проба – 10 ед,
- Глобулины – 54%: α_2 – 19%, γ - 22%, СОЭ 28 мм/ч.
- Гепатомегалия - печень – 14-13-10 см., плотная, край закругленный, ровный.
- Боль в правом подреберье, край печени при пальпации болезненный.

Патогенез: Активация ретикуло-эдотелиальной системы. Повышение температуры, увеличение α_2-глобулинов, γ- глобулинов, тимоловой пробы свидетельствует о воспалении мезенхимальной ткани печени. Боли в правом подреберье появляются вследствие увеличения размеров печени и, как

следствие этого, перерастяжения её оболочки, а также при переходе воспалительного процесса на глиссонову капсулу.

4. Синдром клинико-анамнестический.

– Болен около двух лет (говорит об остроте процесса);

- Злоупотребляет алкоголем более 15 лет (связь заболевания с токсическим воздействием алкоголя).

- В течение двух недель появление симптомов и ухудшение состояния.

Как видно из анамнеза - заболевание хроническое, так как длится в течение 2-х лет, имеет прогрессирующее течение. В настоящее время имеет место обострение заболевания.

Предварительный диагноз: Хронический гепатит, токсической этиологии, активная фаза. Большая печеночно-клеточная недостаточность. Печеночная энцефалопатия. Печеночно-клеточная желтуха. Гепатомегалия. Геморрагический синдром. Кахексия. Анемия легкой степени тяжести.

План обследования, ожидаемые результаты:

1. Биохимический анализ крови: повышение ГГТП, ЩФ, ЛДГ,АСТ; определение уровня глюкозы, ТГ, холестерина, факторов свертывания крови, сывороточного железа, сулемовой пробы.

2.ОАМ: моча темного цвета, появление билирубина.

3.Копрограмма, кал на скрытую кровь: снижение уровня стеркобилина.

4.Ультразвуковое сканирование печени: гепатомегалия.

5.Радиоизотопное сканирование печени: гепатомегалия, диффузный характер поражения.

6. Пункционная биопсия печени: некрозы гепатоцитов, алкогольный гиалин (тельца Мэллори), нейтрофильная инфильтрация, жировая дистрофия.

7. Анализ крови на серологические маркеры вирусов гепатита В, С: отрицательные.

Принципы лечения.

1. Режим постельный.

2. Диета № 5 (с ограничением белка до уровня, при котором не появляются симптомы аммиачной интоксикации, бессолевая – при асците). Отказ от алкоголя.

3. Препараты, улучшающие обмен печеночных клеток (гепатопротекторы): витамины, липоевая кислота, глютаминовая кислота, эссенциале, гептрал.

4. Детоксикационные мероприятия: 5-10% глюкоза+ аскорбиновая кислота или липоевая кислота.

5. При наличии носовых кровотечений – гемостатическая терапия.

6. Препараты железа для лечения анемии.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник – 6 е изд -М., 2009 -656 с
2. Мухин Н. А., Моисеев В.С.. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник -4.е изд - М., 2009. – 848 с.

Дополнительная литература

1. Гастроэнтерология: национальное руководство /под ред В.Т Ивашенко, Т.Л.Лапиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-704с
2. Руководство по гастроэнтерологи / под ред Ф.И. Комарова, С.П.Раппорта. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2010 -804 с
3. Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерологи: избранные разделы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с